

본과 1 학년 가이드라인

*본과 1 학년 담당교수님 'Since' 정보는 동산의료원에서 근무를 시작하신 해를 기준으로 정리한 것이므로 야마와 일치하지 않을 수 있습니다.

1 학기

1. 기초신경	2
2. 감염(1)	6
3. 진단: 영상과 검사	10
4. 외과총론	14
5. 호흡기	20
6. 순환기	28

2 학기

1. 소화기(1)	43
2. 소화기(2)	55
3. 내분비	66
4. 신경계	79

Last update: 2025 년 2 학기

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	기초신경		학점	2 학점
과목 요약	본격적인 신경계 과목 전, 기초적인 지식을 쌓기 위해 배우는 과목이다. 뇌의 구조와 기능, 뇌신경, 척수신경로, 뇌혈관, 신경과 관련된 기초 생리 등을 배운다. 많은 비중을 차지했던 이현수, 엄기상 교수님의 수업이 없어지고, 김대광, 김엘, 권민용, 권세민, 김재현 교수님 수업이 새로 생겼다. 배재훈, 송대규, 박재형, 홍정호 교수님께서 들어오신다.			
올해 경향	✓ 참공이 필요한 엄기상 교수님 수업이 없어졌다. ✓ 겹치는 내용이 많아 반복된 파트는 비교적 공부하기 수월했다. ✓ 1 년 반을 쉬고 공부하는 첫 과목이라 처음엔 다들 버거워했지만, 야마를 많이 타주시고 권민용, 김재현 교수님이 문제를 알려주셨다. ✓ 대부분 신경계에서 디벨롭해서 배우니 기초신경을 미리 들어두면 신경계 들을 때 도움이 될 것이다. ✓ 인구기 골학 & 해부학이 도움되니 참고하면 좋을 것 같다.			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
이현수		O	20	*23: 야마 탄다. 교수님께서 수업시간에 강조한 부분에서 대부분 내시는 편/ 태깅도 중요시 하셨다. *22: 올해는 기출과 똑같거나 비슷하게 출제한 문제가 5~6 문제 있었음. 수업 잘 듣고 강조하신 거 공부하면 문제는 어렵지 않았음. 해부학적으로 중요하다고 하시거나 한번이라도 언급하신 구조물에서 문제를 내시니 슬라이드에 다른 부분 자세히 보지 말고 중요하다고 언급하신 구조물만 눈여겨보면 될 것 같다. *21: 야마 안 타시는 걸로 기억한다. 수업 재밌게 하시고 강조하신 부분에서 출제하신다. 다만 기초신경인 경우 이현수 교수님께서 들어오시는 과목 수가 많고 조금 어렵게 출제
박재형	O		고대	*25: 역시나 야마 타셨고, 새로운 한 문제가 있었다. 신경로는 내림신경로 중심으로 수업하신다. '시상하부와 뇌하수체'는 새로 생긴 수업이었는데, 문제 지문이 길어서 놀랐지만 수업 중 강조하신 부분이고 쉬워서 안심했다.

				*23: 강의록에 있는 문제에서 나오고, 나머지 문제들도 야마 타서 쉽다. *22: PPT 중간에 넣어주시는 문제에서 일단 내시고, 나머지 문제들은 단순암기로 쉽게 풀 수 있는 문제들을 내셨다. 강의 중간에 강조하신 내용들을 알고 있으면 쉽게 풀 수 있을 것. 야마 타셨다. *21: 야마 많이 타신다. 강조하신 부분 잘 보고 가자.
송대규	○		고대	*25: 올해는 야마를 많이 타신 것 같다. 다른 과목에서는 출제 내용을 알려주시기까지 하셨는데, 힘든 년도라 그런 것 같기도 하다. 강의를 듣다 보면 뭐라고 하시는지 머리에 잘 입력이 안돼서 스트레스 받을 수 있는데, 나중에 강의록 찬찬히 읽어보면 되니 걱정마라. 그림이나 사진으로 설명된 내용에서 많이 출제하신다. *23: 야마와 유사한 문제를 내시니 야마를 열심히 공부할 것, 다만 강의록에 없는 문제도 출제하시고 약리학 내용 문제도 출제하셔서 풀기 쉽지 않다. 강의록의 모든 텍스트를 알고 있어야 될 듯하다... *22: 거의 강조하신 모든 구절을 알고있어야 풀 수 있는 문제가 많음 자율신경계 부분에서는 강의록에 없는 부분도 내셨지만, 야마에는 유사한 문제가 존재하기에 야마와 텍스트를 전부 알아두는 게 좋을 것 같음. (그렇지만 아시다시피 야마를 많이 타시는 편은 아니다) 학번 수업 분위기에 따라 문제 난이도가 많이 달라지는 것 같다. *21: 아마도 여러분께 가장 익숙할 교수님. 야마를 아예 안 타시는 건 아닌데 기초신경은 야마가 적을 것이다. 큰 줄기에서 잘 안내시고 지엽적인 부분에서 자주 출제하신다. 그림, 그래프를 설명하셨다면 거기서도 출제 가능.
배재훈			고대	*23: 교수님 강의력이 너무 좋으셔서 엄기상 교수님이나 이현수 교수님 파트 이해 안되는 부분은 배재훈 교수님 수업으로 이해하면 된다. 교수님이 강조하신 부분에서 문제 출제하시고 도표나 그림으로 설명하셔서 이해하기 쉽다. *22: 운동신경계의 경로와 각각의 기관이 하는 역할을 알고 있으면 보다 쉽게 풀린다. 특히 도표 형태로 경로를 비교해 놓은 부분에서 문제를 많이 내시는 것 같다. 강의록을 너무 자세히 볼 필요는 없고,

				수업 중에 강조하신 부분 위주로 알고 있으면 된다. 참공해야할 내용이 꽤 된다. *21: 수업태도 중요하다. 야마 어느정도 타시기는 하는데 변형하시는 경우도 있으시니 그냥 야마 먼저 살펴보고 순공
홍정호				*25: 수업은 들어오셨으나 문제는 출제하지 않으셨다. *23: 서술형 문제 출제하시는데 21 학번에게는 수업 중에 문제를 알려주지 않아 시험 치며 당황했었다. *22: 시험에 서술형 문제로 4 차 산업 관련 신경과학 연구 미래 2000 자 내외 서술하라고 하나 내셨음. 수업 중에 문제 이렇게 낼 것이라 알려주셨다.
엄기상		O		*23: 문제공개/야마안탐, 신경로 문제를 많이 내신다. 수업이 어렵고 강의록도 보기 힘들다. 올해 강의록에 틀린 부분이 종종 있었다. 이현수 교수님이나 배재훈 교수님과 겹치는 부분에서 상충되는 부분이 있을 때, 교수님께 질문하면 정정해주신다. 마찬가지로 시험에서도 오타가 있어 전원 정답처리 되는 경우가 있었다. 작년(22 년)에는 모두 고르는 문제가 많이 나왔었는데, 23 년도는 출제하지 않았다. 신경과학의 최신연구와 응용 파트는 수업을 하셨으나, 수업 내용으로는 풀기 힘든 문제가 나와, 배경지식으로 풀던가 국어 비문학 풀 듯이 보아야 한다. *22: 강의록이 상당히 보기 어렵게 되어있고 수업을 이해하기 힘들다. 그렇지만 막상 수업에서 "이 부분 중요합니다" 라고 조금이라도 언급한 부분에서 내시긴 했다. 올해는 문제 출제 하심. 문제 공개하는 대신 야마 안 탈 거라고 이야기하셨던 것 같음. 사진에서 위치보고 신경로, 핵 뭘지 알 수 있어야 함.
김대광			25	*25: 엄기상 교수님 '신경계통의 미세구조'와 이현수 교수님 '척수와 신경로의 구조적 이해와 용어'를 맡아 올해 처음 기초신경 수업에 들어오셨다. '신경계통의 미세구조'에서는 신경세포의 구조적 분류와 신경아교세포가 중요하다고 짚어주셨고, 그 내용에서 출제되었다. '척수와 신경로의 구조적 이해'에서는 많이 설명하신 부분에서 출제하셨으니, 오래 머물렀던 페이지일수록 신경쓰자. 특히 척수신경로 강조하셨으니 각 tract 경로를 잘 파악하자.

김엘			25	*25: 믿고 듣는 김엘 교수님. 수업은 비록 난해할 지라도 야마를 타시니 믿고 공부하면 된다. 신경계 문제를 참고하자.
권민용			25	*25: '뇌혈관의 구조와 해부'는 새로 생긴 수업이다. 수업 마지막에 문제 출제할 내용 2 가지씩 알려주신다. 수업 중 '집중해라, 이것만 봐라'하고 알려주시는데, 정말 그 부분만 봐도 된다...!
권세민			25	*25: 권세민 교수님을 비롯한 임상 교수님들은 거진 출제하신다고 말씀하신 곳에서 출제하시니 믿으면 된다.
김재현			25	*25: 마찬가지로 출제하신다고 하셨던 곳에서 출제하신다. 문제를 어렵지 않게 내는 편이시니 편하게 공부하면 된다.

과목명	감염(1)	학점	3 학점
과목 요약	의기질(2)에서 미생물학의 총론을 배웠다면, 감염(1)에서는 각론(ex. 세균 각각의 특징 & 관련된 질병)을 배운다. 암기해야 할 내용이 정말 많기 때문에 수업을 듣고 내용 정리와 암기를 바로 해두는 것이 좋다. 23년부터 기초신경과 감염(1)을 같이 배우기 때문에 미리 공부하지 않으면 매우 힘들 수 있다. 담당 교수님은 서성일 간사 교수님, 백원기 책임 교수님, 김진경 교수님이 들어오신다. 김진경 교수님은 올해부터 서민호 교수님 대신 들어오셨다. 1 차 시험은 세균과 진균이, 2 차 시험은 바이러스와 기생충이 시험 범위이다. 지금까지 그 어느 과목보다 기출문제가 중요하다. 특히 백원기 교수님은 기출문제를 베이스로 문제를 출제하셨다. 큰 분류체계를 만들고 외우면 도움이 된다. 야마변형이 많으니 문제와 선지 잘 읽기!		
올해 경향	세균 10: 진균 1의 비율로 시험이 진행되었으며, 실습시험도 함께 보았다. 세균의 내용이 워낙 많고, 헛갈리기 때문에 배운 내용을 본인 방식으로 잘 정리하는 게 좋다. 특히 세균들끼리 연계되는 내용, 그 세균만의 특징적인 내용 등이 중요하지만... 결국 다 외우게 된다. 똑같은 카테고리의 특징을(서식, 병원, 증상, 치료 등) 세균 별로 외워야 하기 때문에, 나중에는 이 특징이 A 세균이 가지는 특징인지, B 세균이 가지는 특징인지 굉장히 헛갈리며, 교수님들도 이런 부분에서 많이 출제하신다. 야마를 여러 번 풀어보며 자신이 정말 아는 것인지 체크하는 것이 중요하다. 25 : 세균, 바이러스, 기생충이 대부분을 차지하며 극소량의 진균 내용도 같이 배웁니다. 감염(1) 시험 때 실습시험도 함께 칩니다. 대부분 야마나 형성평가 그대로 혹은 약간 변형해서 나왔습니다. 세균 내용이 워낙 많아서 힘듭니다. 개인적으로, 표로 만들어서 보는 게 크게 도움이 되었습니다. 세균별로 핵심적인 특징, 면역 회피 체계 등을 포함한 여러 정보를 잘 정리해서 보시는 걸 추천합니다. 바이러스는 세균보다는 쉬웠으나 RNA virus의 양이 너무 많기 때문에 YBL을 추천합니다. 기생충 역시 양이 너무 많으며 용어가 너무 어렵습니다. 기생충 파트는 특히 형성평가 문제를 많이 주셨고 대부분이 야마나 형성평가에서 나왔습니다. 핵심만 뽑아 잘 정리해서 보시는 걸 추천합니다.		

교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
서성일	0		고대	수업에 가장 많이 들어오시며, 시험문제 출제 역시 가장 비중이 높다. 수업을 진행할 때 '질병 / 주요특성 / 전파 / 병인 / 임상증상 /진단' 순으로 균을 설명하시기 때문에, 표를 만들어 외우면 도움이 된다. 문제 출제 방식은 "다음 중 가장 옳은 것/ 틀린 것 한 가지를 고르시오 1. 특징 A, 2. 특징 B, 3. Both, 4. Neither" 로 순간적으로 헷갈리기 정말 좋으니, 균마다의 특징을 정확하게 아는 것이 아주 중요하다. 야마에서 선지변형이 정말 많다. 꼭 풀어보기! 기생충 이름을 물어보는 주관식 문제가 나오기도 한다. 25 : 감염(1) 수업 시간 중 절반 이상을 들어오십니다. 세균, DNA Virus, 기생충까지 많은 부분을 수업하십니다. 감염은 외울 게 많아서 처음부터 다들 힘들어했던 과목이었고 특히나 서성일 교수님 파트가 양이 많았습니다. 그래도 강의록을 다 볼 필요 없이 교수님께서 수업 시간에 강조하신 것 위주로, 언급하신 것들만 보면 됩니다. 수업 중간에 계속 질문하시는데(e.g. 요로감염 일으킬 수 있는 균 3개는?) 그런 내용들은 꼭 외우셔야 합니다. 형성평가 문제들을 많이 넣어두셨고 시험 전에 형성평가 잘 보라고 말씀해 주셨으며 실제로 형성평가 문제가 그대로 혹은 변형돼서 많이 나왔습니다. 바이러스 간염은 소화기(1)에서도 나오기 때문에 잘 공부해두시면 좋을 것 같습니다. 기생충은 이름과 분류부터 너무 어렵고 양도 너무 많았는데, 교수님께서도 이를 알고 계셔서 최대한 핵심 특징 위주로만 집어주시면서 수업하셨습니다. 기생충 파트에 형성평가 문제를 가장 많이 주셨었으며 실제로 기생충 파트가 형성평가 문제와 가장 유사하게 나왔던 것 같습니다. 개인적으로 줄글 정리본 보다는 같은 카테고리 묶이는 애들을 표로 정리해서 보는 게 많이 도움됐습니다.

백원기	0	고대	공부하는 것을 긍정적으로 생각하신다. 오히려 중요하다고 강조하신다. 세균과 진균을 강의하시며, 야마에서 많이 출제하신다. 세균은 헛갈리기 좋은 세부적인 특징도 출제하시기 때문에 잘 분류하여 외워두는 것이 중요하고, 진균은 야마를 중심으로 공부하면 도움이 된다. 정말 시간이 없으면 야마만이라도 분석하는 것을 추천한다. 25 : 야마를 많이 타시고 야마의 존재를 잘 아시는 교수님 중 한분이십니다. 2025 년 수업에서는 마지막 날 수업에 대한 질문을 받으셨는데 "(야마의) 그대로는 아니다", "10 년치는 가지고 있는 걸로 아는데 (본인의 출제)패턴을 다 알고 있을 것", "중요하다 한 걸 열심히 보라" 라고 하시고는 실제로 문제도 YBL 로 내셨습니다(답은 그대로인데 문제 설명이 바뀌거나 문제와 답이 서로 바뀌거나 하는 문제가 많았습니다). 시험 문제는 수업 중 교수님께서 강조하시는 부분에서 많이 출제되는데, "알고 있어라"라고 하시거나 설명이 길어지시는 부분은 잘 체크하시는 것이 좋습니다. 강의록 양이 보통 많은데 안 봐도 되는 부분은 X자를 쳐 주십니다. 해당 부분은 정말 안 보셔도 됩니다. 한국에 잘 없는 균이나 바이러스라고 언급하시는 부분 역시 '크게 중요하지 않다'라는 뜻으로 넘어가시면 될 것 같습니다. 2025 년 수업에서는 마지막 날 시험 문제에 대한 질문을 받으셨습니다. 본인이 어떻게 문제를 출제했는지를 확인하시고 오셔서 자세히 알려주셨습니다. 'mycology 총론 리뷰' 강의록을 따로 주시고 수업을 별도로 진행하지 않으셨는데 문제를 짚어주셨습니다(전날 동기가 물어봤는데 출제했는지 안 했는지 기억이 안 난다고 하시고 그 다음날 확인해 주셨습니다)
-----	---	----	---

김진경			고대	*23: 새로 오신 교수님이라 처음 보는 문제들도 꽤 있었다. 하지만 야마와 거의 똑같은 문제도 출제하시므로 최근 기출 문제는 풀어봐야 한다. 수업시간에 강조하시는 부분(빨간색 밑줄) 위주로 출제하시는 것 같다. 25 : 야마 타시고(서민호 교수님 야마), 강의록에 빨간색 부분 위주로 출제하십니다. 그리고 볼드체도 선지에 나오니 잘 봐두시기 바랍니다. 한번씩 수업 중에 이런 문제 냈다 eg) 결핵약 종류. 이런 말도 해주십니다. 수업 잘 듣고 중요한 부분 (빨간색,볼드체) 위주로 보시면 될 것 같습니다. 강의 자체는 강의록 전체를 훑으시는 무난한 스타일이셔서 부담없이 들으실 수 있습니다. 시험은 어렵게 출제하시지 않기 때문에 세세한 내용까지 다 알 필요는 없습니다. 야마 부분 위주로 먼저 공부하시는 것을 추천드립니다.
-----	--	--	----	--

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	진단: 영상과 검사			학점 1 학점
과목 요약	세 번째 블록으로 해부학에서 배운 내용을 X-ray, CT, MRI 등 영상의학 관점에서 한번 더 배운다고 생각하면 된다. 시험이 야마를 기반으로 많이 출제되고 암기할 내용도 앞의 두 블록보다 훨씬 적다. 하지만 시수가 적어 시험이 금방 다가오기 때문에 쉬운 과목이라고 수업을 미루는 것은 좋지 않은 선택이다. 야마는 M3 1 학기의 진단:영상과 검사, M3 2 학기의 (구)임상의학총론(1)을 보면 된다.			
올해 경향	✓ 거의 풀야마였다. 무조건 야마부터 공부하자. ✓ 야마를 위주로 공부하는 것은 중요하지만, 강의록을 너무 버려두진 말자. ✓ LMS 성적공개 안하셨습니다.			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
이재혁	O		17~	*25: 문제 출제될 부분 집어주십니다. 그 부분을 정확하게 공부하면 쉽게 맞출 수 있습니다. 이번엔 집어준 부분에서만 내셨습니다. *23: 수업시간에 시험에 출제하신 부분 짚어주신다. 꼼꼼히 외우고 들어가자. 물론 짚어주신 부분을 공부해도 풀기 쉽지 않은 문제가 섞여 나오는 경우도 있다. *22: 21 학년도와 마찬가지로 방사선 파트는 집어주신 파트만 봐선 안된다. 그 외의 개념에서도 많이 출제되었기 때문에 참공부하는 것을 추천한다. 근골격계는 처음부터 쪽 설명을 하시다 시간이 부족해 어디어디에서 출제하셨다 집어주셨고, 그대로 단순하게 출제되었다. *21: 방사선파트는 야마를 계속 응용해서 내시기 때문에 기본 개념을 잘 익혀야한다. (한마디로 참공부) 근골격계 파트는 교수님께서 집어주신 부분에서 출제되었다.
김미정	O		17~	*25: 1 문제 빼고는 풀야마를 타셨습니다. 새로 출제하신 문제마저 매우 쉽게 출제하셨습니다. 특히 소화기 영상 강의록은 너무 양도 많고 빨리 지나가셔서 공부하기 막막했지만 풀야마였습니다. 너무 부담 안가지셔도 될 것 같습니다. *23: 문제를 많이 까다롭게 출제하진 않으셨다. 강의록을 너무 꼼꼼하게 보기 보다는 크게크게 보는 것을 추천한다. *22: lesser sac 문제 빼고 모두 야마와 동일하게 출제되었다.

				복기본에는 없지만 mesentery proper 과 greater omentum 구분하는 문제(야마)도 출제되었던 것으로 기억한다. *21: 1 문제 빼고 모두 야마 출제
이상권	O		17~	*23: 원래 거의 풀야마였으나 탈야마를 하셔서 당황한 학생들이 많았다. 물론 완전 이상한 부분에서 낸 것이 아니라 수업시간에 강조하신 부분이었기에 앞으로는 야마+강조한 부분을 주의깊게 공부하는 것이 좋을 것 같다. *22, 21: 야마에서 그대로 출제되었다.
김진영	O		17~	*23: 야마에서 크게 벗어나지 않고 출제하신다. 야마와 강의록을 같이 보면서 공부하는 것을 추천한다. *22: 대표적인 개념을 출제하시기 때문에 강의 내용을 이해하고 야마에 출제되었던 부분을 꼼꼼히 공부하면 충분할 것이다. *21: 야마 그대로 내시거나 변형해서 내신다. 야마 부분만 공부!
이희정	O		17~	*25: 진검 파트는 야마 변형으로 주로 출제하십니다. 야마 부분 2 문제 (초음파 artifact, 후복막강 장기)을 위주로 먼저 공부하는 것을 추천합니다. *23: 야마 변형으로 출제를 많이 하신다. *22: Artifacts 와 retroperitoneal space 에 관한 문제가 출제되었다. 야마를 참고하여 retroperitoneal space 에 속하는 장기들, 각각의 3 spaces 에 속하는 장기들에 대해 확실하게 공부해두면 좋을 것 같다. *21: 초음파의 과학(?)과 관련된 부분에서는 거의 출제 안하고 kidney, retroperitoneal organ 과 관련된 해부학적 지식에 대해 출제.
이무숙	O		17~	*25: 문제 출제될 부분을 집어주십니다. 그 부분을 정확하게 공부하면 쉽게 맞출 수 있습니다. *23: 수업시간에 푼 퀴즈에서 문제를 출제하셨다. *22: 혈관 영상해부 1 문제(야마), 인터벤션 기술 1 문제(야마 변형) 출제하셨다. 강의록 사진을 사용하시니 개념과 사진을 매치하여 잘 외워두는 것이 필요할 것 같다. *21: 해부학 관련 문제 1 문제(야마), 사진자료 관련된 해부/인터벤션 기술 1 문제(탈야마) 내신다. 사진은 강의록에서 출제하심.

박성균	O		17~	*23: 풀야마 *22: 이번 학년도엔 대부분 야마를 변형하여 출제하셨다. *21: 20 야마랑 토시 하나 안 바꾸고 출제하심.
송봉일	O		17~	*25: 문제 출제될 부분을 집어주십니다. 그 부분을 정확하게 공부하면 쉽게 맞출 수 있습니다. *23: 야마 잘 태워주신다. 특히 반감기 계산 문제는 항상 출제하신다. *22: 유효 반감기 계산 문제와 방사성의약품의 특징을 주시고 어떤 의약품인지 맞추는 문제를 주로 출제하신다. 중요하다고 말씀해주시므로 수업시간에 잘 듣고 그것 위주로 공부하면 충분할 것 같다. *21: 유효 반감기 구하기, 방사성의약품의 생산 부분에서 집중적으로 출제됩니다. 그 밑에 scan image 에서는 출제 된 적이 없네요.
김해원		O	17~	*23: 야마는 당연히 잘 보고 강의록에서는 사진을 잘 봐둬야 한다. *22: 핵의학 영상의 개념 관련 문제, case 와 핵의학검사 사진을 보고 사용된 방사성의약품과 영상검사의 이름을 맞추는 문제가 하나씩 주로 출제된다. 야마를 보고 문제 유형을 확인한 뒤 공부하는 것을 추천한다. *21: 영상 사진을 보고 명칭과 사용 방사선의약품 종류에 대해 출제
권선영	O		17~ 22	*22: 21 학년도와 마찬가지로, 야마를 변형하여 출제하셨다. 주로 내시는 부분을 체크하고 그 부분을 확실하게 공부해두면 될 것 같다. *21: 출제되는 부분에서만 출제. 야마 그대로 출제되진 않는다.
황일선			23~	*25: 강의시간에 강조해주시는 부분이 없어 모든 내용을 공부해야하나, 양이 그렇게 많지 않아서 참공해도 시간이 크게 걸리지 않았습니다. *23: 23 년부터 들어오셨다. 강의록이 글씨가 거의 없었고 시험치고 나와서 답의 근거를 찾기도 힘들었다. 문제가 까다롭진 않았다.

홍정희	O			25:김진영 교수님이 출제하신 문제 그대로 출제하셨습니다. 추가로 22 학번에선 모든 과목 통틀어 홍정희 교수님은 과거 영상파트 담당 교수님들의 야마를 그대로 다 내셨습니다.
김영환	O			25:문제를 다 보여주셨습니다. 보여주신 문제 그대로 출제하셨습니다.
강혜인	O			25:문제 출제될 부분을 집어주십니다. 그 부분을 정확하게 공부하면 쉽게 맞출 수 있습니다.

본과 1 학년 가이드라인			
과목명	외과총론		1 학점
과목 요약			
올해 경향	*25: 본 1 과목 중 가장 편하게 들을 수 있었던 과목이었습니다. 야마를 많이 타시고 새롭게 들어오신 교수님들께서도 대부분 중요한 부분을 수업 중에 강조해 주셨으며 그러한 부분에서 출제하셨습니다. ----- *23: 대부분 야마를 타시거나 강조해주신 부분에서 내셨습니다. 오히려, 류승완 교수님 파트를 쉽게 생각해 방심하여 틀리는 경우가 다수 있었습니다. ----- *22: 추가적으로 한글파일 강의록은 잘 사용되지 않으나 수업시간에 배운 내용을 한글파일 강의록에서 문장 그대로 출제하신 경우가 있었습니다. 다른 공부를 '다 하셨다면' 한글파일 강의록도 훑어 보시길 추천드립니다. ----- *21: 외과총론 과목은 1 학점으로 작년까지 매우 쉽고 야마를 많이 타서 점수가 높게 나오는 과목이라고 하였지만 이번 년도 전반적으로 거의 대부분 탈야마하셨습니다. 점수가 낮은 학생이 많아 재시를 주셨습니다. 강구정, 김형태, 구은정, 류승완 교수님 외에는 교수님마다 강의 파트가 바뀌어서 새로운 문제가 다수 출제되었습니다. 강의 PPT 뿐만 아니라 A4 강의록을 봐야 명확하게 풀 수 있는 문제도 있었습니다. 강의록과 야마에서 본 적 없던 사진도 제시되었습니다.		
교수님	(O 표시)	Since	출제 성향
	YBL 안탐		

강구정			고대	*23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21: 유일하게 줌으로 수업하셨습니다. 강구정 교수님께서 중요한 부분을 강조해주시기는 하셨지만 답을 찾는 데는 애매한 부분이 있었던 것 같습니다. 재시문제에서는 지엽적으로 나왔었던 것으로 기억합니다. *구 가이드: 간담체 외과 교수님. 외과 pride 가 장난 아니시다. 수업은 교재와 ppt 로 하신다. 18 년에는 늦으셔서 교재만 하시고 뒷부분 ppt 는 못 나갔는데 문제는 거기서 안 나옴. 문제는 야마 보면 된다. 임총 수업 중 의료인문학 수업이 있는데 머릿속에 잘 들어오진 않지만 시험 문제는 두 문제 전부 5)모두 맞다 로 쉽게 내주심 19 년도에는 의료인문학 수업이 임총에 서 빠지고 소화기 때 잠시 하셨다. 문제는 안 나옴.
안근수				*25: 기존에 강구정 교수님께서 담당하셨던 외과의 역사 파트를 강의하셨습니다. 수업은 편하게 들으면 된다고 하셨고 어떤 부분에서 출제하셨는지 알려주셨으며 그대로 출제하셨습니다.

백성규			고대	*25: 올해는 소화기 과목과 마찬가지로 수업이 끝나고 출제하신 문제들을 직접 화면으로 보여주셨습니다. 하지만, 소화기 과목 때와는 달리 한 문제가 선지 및 문항이 아주 살짝 변형되었는데 기존 정답선지를 포함하여 두 세 선지가 바뀌어 가장 많은 논란이 있었던 문제였습니다(가이드라인 작성 시점에서는 정답이 확정되어 22 번 문항 답은 4 번입니다) 강의는 무난하고 특이사항이 없지만 만약 문제를 보여주시지 않는다면 강의록 양은 다소 많을 수는 있습니다. *23: 빨간색, 또는 강조하시는 부분을 잘 보시면 됩니다. *21: PPT 를 꼼꼼히 공부하고 전반적으로 내용에 대해 이해하는 것이 중요할 것 같습니다. *구 가이드: ppt 로 수업하심. 무난하다. 차렷/경례 시키시니 눈 치껏 교수님이 강단 앞에서 서 계시면 일어나서 그냥 차렷
-----	--	--	----	---

				경력~ 하면 됨. 딱딱한 분위기 아님. 다만, 인사드려야하니 수업 전에 애들 다 들어와 있도록 전달 공지하기.
정운경			고대	*25 : 특이사항 없고 풀야마 타셨습니다. *23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21: 전에 담당하시던 부분이 아닌 창상치유 파트로 수업이 들어오셔서 관련된 교수님 야마가 없었다. 대신 수업은 그 전에 수업 들어오신 손영길 교수님 강의록을 그대로 사용하셨는데 수업을 되게 크게크게 수업하시고 문제도 염증의 5 징후 같이 큰 카테고리에서 문제를 내셨다. *구 가이드: 대장항문외과 교수님. 외과 종양학 수업하신다. 양은 많은데 18 년에는 다 집어주셨다. 시험 문제도 무난했음 다만 12p 인지 12q 인지 이런것만 조심하면 된다 19 년에는 늘 나오던 그림이었는데 훨씬 꼼꼼하게 물으셨다.
손영길			15'~	*25: 세세한 부분까지 외우기보다는 중요한 것과 야마 위주로 공부하는 것이 도움될 것입니다. 수업도 잘 하시고 문제도 야마 위주로 출제하셨습니다. 시간이 되신다면 구야마까지 볼 수 있으면 좋을 것 같습니다 *23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21 년: 강조해주신 것만 꼼꼼히 보면 되었다! (모든 표를 외울라고 하면 스트레스만 받을 것이다...) *구 가이드: 수업 명쾌!! 이해하기도 쉽고 야마도 적당히 탐.
이무현			17'~	*25: 올해는 들어오지 않으셨습니다. *23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21 년: 중요한 부분은 확실한 짚어줬으나 정말 꼼꼼하게 다 외우지 않으면 틀릴 수 있는 문제를 1 개 내셨다. 그래도 수업은 깔끔하고 강조를 확실히 해주셔서 공부하기는 편한 교수님이시다. *구 가이드: 감사 교수님. 시험 일정 잡을 때 연락 드리면 된 다!! 양은 조금 많았지만 다 집어 주셨다!! 문제도 무난 하였 다

조지형			고대	*25: 올해는 들어오지 않으셨습니다. *23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21 년: 강의는 무난했으나 시험문제가 너무 어려웠다. 분명 공부를 다했는데 문제를 보고 당황했었다. 진정한 참공부가 필요한 부분이다. *구 가이드: 야마 선지 정리. 19 년도에는 마지막에 중요 내용 정리해주셨는데, 안 탄 문제는 거기서 나왔다.
강선희			고대	*25: 올해는 들어오지 않으셨습니다. *23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21 년: 비대면 수업이라 수업 자체는 무난했으며 문제도 서술형이 나온다고 해서 어렵게 나올 줄 알았으나 상식으로도 풀 수 있는 문제가 나왔고 나머지 한 문제도 수업의 큰 흐름만 잡으면 풀 수 있게 출제하셨다. *구 가이드: 1 학기 수업 중 가장 수업 태도에 주의해야 할 유방내분비외과 여교수님!! 지각/결석/대출 절대 금지이며 수업 때 <u>선배필기 절대 금지</u>. 교재'만' 펴두기. 당연히 KMLE 도 집어넣기. 수업 하실 때 무선 마이크 들고 돌아다니시고 마이크 학생 입에 대면서 질문하시는데, 대답 못하면 갑분싸 됨. 오답이라도 좋으니 뭐라도 대답하면 됨. 18 년 업데이트 : 수업 끝나고 필기총이 강의록을 받으러 나갔는데, "저기 있네^^" 라고 손가락을 가르키셨는데, 우리 학번 맨 앞자리 친구가 모르고 선배필기를 꺼내놓은 걸 보신 것. 야마는 항상 타시다가 18 년에 사진 위주로 바꾸셨는데 못 풀 정도는 아님. 야마 믿다가 틀린 친구들이 좀 있었다. 19 년도에도 사진 위주! 강조하신 부분에서 나온다.
김용훈			고대	*25: 특이사항 없고 풀야마 타셨습니다. *23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21 년: 최소침습수술의 특징과 각 수술의 특징만 대충 보고 들어가면 맞출 수 있게 문제를 내셨다. 수업 자체도 무난하다. *구 가이드: 수업 태도에 필히 주의!! 무난하다

구은정			18'~	*25: 올해는 들어오시지 않으셨으며 소아 파트는 정은영 교수님께서 들어오셨습니다. 23: 별다른 특이사항 없음(야마 or 야마 변형) *21 년도에 소아 관련 내용으로 들어오셨는데 수업 자체를 너무 잘하신다. 하지만 문제 한 개가 수업을 완전히 이해해도 풀기 어려웠던 문제가 있어서 참공부를 추천한다!
정은영			고대	25 : 강의를 매우 잘해주시며 출제하신 부분은 수업 중에 별표 쳐주시면서 수업하십니다. 실제로 별표 치신 부분에서만 출제하시며 어렵지 않고 수업을 열심히 들으면 도움이 많이 됩니다. 정은영 교수님 야마 문제는 고대야마를 보셔야 합니다.
류승완			고대	25 : 올해는 풀야마 타셨습니다. 그렇지만 전부 구야마(2017, 2020)에서 출제하셨기에 고대야마까지 보는 것을 추천드립니다. 강의는 재밌게 해주시고 편하게 들을 수 있지만, 막상 공부할 때는 어떻게 해야 할지 감을 잡기 어려우실 수도 있습니다. 야마 위주로(고대까지) 학습하시고 중요하다고 하신 부분 위주로 공부하시면 좋을 것 같습니다. *23: 이번에는 생각지도 못한 부분에서 내셨어서, 강의록을 꼼꼼하게 정독하시면 좋을 것 같습니다. *21: 무난하고 수업자체도 재밌고 문제도 무난하게 내주셨다. *구 가이드: 야마 선지 정리. 19 년도에는 마지막에 중요 내용 정리해주셨는데, 안 탄 문제는 거기서 나왔다.
김민재			25'~	25 : 장기이식파트 두 시간은 어디서 출제하셨는지 알려주셨고 그대로 출제하셨습니다. 고령환자 파트의 경우는 따로 강조해주신 부분은 없으나 문제는 아주 쉽게 상식적으로도 풀 수 있을 정도로 출제되었습니다.
박찬희			22'~	25 : 갓찬희 교수님. 풀야마. 수업 시작할 때 작년과 동일하게 출제하셨다고 말씀하셨고 실제로 그대로 출제하셨습니다.

이정우			23'~	25 : 2 문제 중 한 문제는 어떤 스타일로 출제하셨는지 알려주셨으며 다른 문제도 강조한 부분에서 크게 어렵게 내시지 않으셨습니다. 특히 내용이 손영길 교수님 강의 내용과 아주 많이 겹치므로 참고하시면 좋을 것 같습니다.
-----	--	--	------	--

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	호흡기		학점	4 학점
과목 요약	야마가 매우매우 적다. Kmle 보면 큰 도움 교수님들이 말씀은 안하시지만 KMLE 와 유사하게 출제하시는 교수님들이 많다. 미리 문제를 다 출제 해놓으시기 때문에 강조하시는 부분 잘 들으면 도움된다. 그러나 수업할 때 되면 어떤 문제를 내셨는지 까먹으시는 경우가 종종 있다. 시간당 2 문제			
올해 경향	*25: 전반적인 경향은 동일, 다만 교수님별 수업해주시는 차시가 많이 바뀌면서 어떤 형식으로 출제될지 가늠이 어려웠던 부분들도 있었다. 대체로 양이 많고 주로 KMLE 형식으로 출제되는 부분과 강의록의 내용을 기반으로 출제되는 부분이 섞여 있어 교수님별/차시별 출제 경향을 잘 파악하고 중요한 부분을 정리해두길 추천한다. ----- *23: 이전 가이드라인과 동일 ----- 가장 Kmle 형식으로 출제됐던 과목이라고 생각된다. 몇 년 치 모인 야마에서 많이 나오고, 해부학 관련 문제들도 공부할 때는 막막했는데, 막상 문제는 야마 변형으로 많이 나왔던 것 같다.			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
박재석	O		14'~	*25: 풀야마였습니다. 수업시간은 풀로 채우시지만, 강의록에 별표도 있고, 수업 때 중요하지 않다고 하시는 건 가볍게 읽고 야마랑 수업 때 강조하신 내용 위주로 보시면 됩니다. 23 년도 복기본 해설에는, 1 차를 잘 쳐서 한 문제를 어렵게 냈다고 하셨는데 저희는 1 차가 워낙 어려웠어서 전부 야마 태워주신 것 같기도 합니다. *23: 야마도 적당히 타시면서 강의록에 별표 표시된 부분과 강조하신 부분에서 문제를 내십니다. 대부분의 문제가 야마에서 환자의 병력 정도만 약간 변형되어 나왔습니다. 다만, 범위가 방대하기 때문에, KMLE 를 참고해서 키워드를 잘 정리 해나가면 좋을 것 같습니다. *22: 강의록에 별표 되어 있는 부분 + 강조하신 부분에서 대 부분 출제되는 듯. 야마도 적당히 태워주신다.

				*구 가이드: 책임교수님. 강의 굉장히 깔끔. 문제도 강의록 내에서 깔끔하고 쉽게 출제하심. 수업 중 강조하시는 것은 꼭 공부하자. KMLE 도 큰 도움이 됨.
채민철	○		20'~	*25: 갓입니다. 풀야마였습니다. 수업 때 강의록을 쪽 읽어주시는 편이라 집중이 잘 안되지만 전부 야마 그대로 태워주시거나 선지만 살짝 변형해서 내시기 때문에 야마만 보셔도 될 듯합니다. 다만, 호흡기 2 차 때는 강의록에서 찾기 힘든 내용들이 야마에 있었는데 그래도 야마 그대로 나오니 걱정 안 하셔도 됩니다. *23: 모든 문제가 야마에서 선지만 변형되어 나왔다. 변형된 선지도 강의록에서 해당 파트의 내용을 그대로 가지고 오신 경우가 많아서 야마 선지 분석 + 해당하는 내용을 자세히 보도록 하자. *22: 8 문제 모두 야마와 완전히 동일하게 또는 선지 변형으로 나왔다. 야마 선지 분석으로 공부하면 충분할 듯. *21: 양이 많아서 막막했는데, 야마 선지 변형으로 출제됐고, 새로 출제한 거는 한 개였음. 참공부는 너무 힘들고, 선지 분석하면서 공부하면 충분할 듯. 다만 강의록은 영어로 되어있는데 시험 문제 보기는 전부 한글로 풀어서 설명되어있음.
금동윤		○	고대	*25: 1 문제 빼고 야마 타거나 야마변형이었던 것 같습니다. 수업 잘 하시는 편이라, 수업 잘 듣고 야마 위주로 앞뒤로 잘 봐두시면 크게 어려움 없을 듯합니다. *23: 작년에도 탈야마 하셨는데 올해도 탈야마 하셨고, 시험장에서 풀기 까다롭고 생소하게 느껴진 문제가 다소 출제되었습니다. 문제는 수업시간에 강조하신 부분에서 주로 출제하십니다. 강의록을 모두 암기할 수 있다면 가장 좋겠지만, 강의록 양이 많아 참공으로 모두 외우기엔 부담이 되고 시간이 부족하시다면 강조하신 부분만 선택과 집중하여 공부하시는 것도 괜찮을 듯합니다. *22: 전반적으로 탈야마입니다... *21: 이 교수님도 해부 맡으셔서 문제내는데 야마 또는 선지 변형으로 출제된다. 채민철 교수님 강의 공부하는 것처럼 하면 될 듯.

배재훈		○	고대	*25: 이전과 동일 *23: 야마를 안타십니다. 다만 이번 1 차 시험에선 한문제는 3 년전 야마를 타셨지만 대체적으로 문제를 새로 출제하시기에 참공하셔야 합니다. 다만, 비슷한 내용의 다른 학번 시험문제 와 기종평에서 문제를 참고하시거나 그대로 출제하시므로 타 학번 문제와 기종평 문제를 구하셔서 강의록과 함께 공부하 시면 좋을 듯합니다. 참공이긴 해도 강의를 워낙 잘하셔서 수업시간에 집중하여 들으시면 충분히 내용을 이해할 수 있습니다. *22: 작년과 동일 *21: 기종평 문제에서도 많이 가져오시기 때문에 여유가 된 다면 다른 학년 문제 + 기종평 문제 풀어보기
김현정	○		18~22	*25: 과목 책임교수님이자, 피드백을 담당해주셨던 교수님이십니다. 주로 KMLE 형식으로 문제를 내시는 것 같은데, 수업해주시는 내용이 포괄적이어서 그런지 배운 질환들 내에서 떠올리기가 쉽지 않았던 문제들이었습니다. KMLE 를 참고하여 전형적인 임상소견에서 우선적으로 감별해야 할 질환들을 잘 정리해 두시는 것을 추천합니다. *23: 수업에 들어오지 않으시고, 김태훈 교수님이 강의하심 *22: 야마를 한두문제는 태워주신다. 검사, 치료 위주로 물어보심. KMLE 유사 문제도 내신다. *21: 양이 방대하여 참공부하기 힘들다. 야마 선지 분석하기
김태훈		○	23~	*25: 원래는 박순호 교수님께서 하시던 파트를 새로 맡으셨습니다. 때문에 야마가 없었으나, 수업 때 강조하신 내용 위주로만 공부하면 됐던 것 같습니다. 다만 폐암 진단을 위한 검사방법 고르는 문제가 그나마 정답률이 낮은 TOP3 였습니다. *23: (1 차 시험) 야마 안타십니다. 수업시간에 강조하신 표와 진단 방법, 진단 소견 등에서 주로 문제를 내시며 강조하지 않으신 부분에서 문제를 내기도 하시니 참공하셔야 합니다. (2 차 시험) 김현정 교수님께서 하시던 파트였고, 예전 야마들 보다 비교적 훨씬 쉬웠습니다. 형성평가랑 강조하신 부분만 잘 봐도 문제를 풀 수 있었습니다.

이성용			고대	*25 : 풀 탈야마. 호흡기 1 차의 경우, 강조하신 부분을 중심으로 출제하셨지만 한 학년 동안의 경향으로 보면 어떻게 출제하실지 가늠이 힘들었던 교수님이십니다. 기전도 함께 알아두시는 게 좋습니다. *23: 갓성용 ♡ *22: 믿고 가자. 풀야마.
장정희		○	고대	*25: 약물의 부작용과 작용기전 위주로 정리하시면 됩니다. 출제하신 두 문제 모두 특징에 해당하는 약물 고르는 유형이었고 그중 한 문제는 야마였습니다. *23: 작용기전과 부작용 위주로 약물 꼼꼼히 정리하시는 걸 추천드립니다. *22: 들어오셨습니다. 문제는 약물에 대한 설명을 쪽 적어놓고 해당되는 약물을 고르는 유형. *구 가이드: 집어 주시는 약 외우고, 야마로 사용하는 경우 정리. 나오는 약이 자주 나온다. 20~21 년은 해외 연수 가서 서, 이성용 교수님께서 대신 들어오셨다.
박순효	○		16'~	*25: 거의 풀야마였습니다. 수업 때도 쉽게 낼 거라고 하였고, 다들 걱정했던 폐암의 병기 설정 문제는 나오지 않았습니다. 폐암의 병기 설정 및 치료는 강의록이 엄청 많지만 야마 위주로만 잘 정리해서 봐도 쉽게 맞힐 수 있도록 출제되었습니다. Kmle 는 필수까진 아니지만 풀어보시면 도움이 됩니다. *23: 풀야마였습니다. *22: 1 차 시험에서 기관지 확장증에 대한 R 형 문제를 내셨는데 오답률 1 위였다. 21,22 년도 경향을 종합해보았을 때 기관지 확장증에서 R 형 문제 내기를 좋아하시는 듯. 2 차 시험은 풀야마. *21: PPT 로 보면 내용 정리가 잘 안될 수 있는데 KMLE 에 잘 정리되어있으니깐 그걸 보고 공부하는 것을 추천한다. 새로운 문제를 굉장히 지엽적인 부분에서 내시는 경우가 있음.

황일선			12'~	*25: 전부 탈야마입니다. 형성평가나 이전 야마에서 그대로 나온 문제가 거의 없었습니다. 게다가 이전에는 내지 않으시던 병리 사진 문제도 내셔서 다들 당황했던 기억이 있습니다. 다만 크게 어렵게 내진 않으셨고, 질환별로 특징을 잡아서 외우면 쉽게 풀리는 문제들이었습니다. 주시는 형성평가와 병리학 교과서를 기반으로 질환별로 잘 정리해서 봐두시는 걸 추천드립니다. *23: (1 차 시험) 야마도 적당히 타시면서 수업시간에 내주시는 형성평가를 선지 변형하여 출제하십니다. 그리고 병리학 책에서 문장 그대로 따와서 선지로 내시기에 해당 범위의 병리학 책도 꼼꼼히 읽어보시면 도움이 될 것 같습니다. (2 차 시험) 항상 강의록 또는 야마를 약간 변형해서 내시다 가, 이번에는 변별력을 위해 평소보다 더 까다롭게 문제를 내셨습니다. 대부분 교과서 내용을 확실히 숙지했을 때 풀 수 있는 문제들이었습니다. *22: 올해에는 시험 문제를 출제하셨다. PBL 수업을 하면 PBL 문제만 그대로 또는 선지 변형해서 내셨다. PBL 이 아니면 LMS 퀴즈 문제를 선지 변형해서 내시고 나머지는 병리학 책을 기반으로 문제를 내신다. *21: 병리파트는 시험 없이 레포트로 대체됨. 수업 자체는 교과서에 있는 내용을 다 설명해주시는 편.
윤성환			24	*25: 처음 들어오셔서 야마가 없었습니다. 빨간색과 별표만 봐도 시험에는 지장이 없을 거라고 하셨는데, 빨간색과 별표가 너무 많았습니다. 사실상 별표가 있는 페이지 + 빨간색 텍스트를 다 봐야 합니다. 문제도 형성평가처럼 쉽게 나오지 않았고, 병력과 검사소견을 준 후 추정되는 질환에 대한 설명 중 틀린 내용을 고르는 문제들이었습니다. 소거법으로 풀 수 있긴 하나 한 두개씩 헛갈리는 선지들이 있었던 걸로 보면 꼼꼼하게 공부하시는 걸 추천드립니다. Kmlle 풀어보시면 좋습니다.
김경태			22~	*25: 한 문제는 야마 타셨고, 한 문제는 새로 내셨습니다. 다음 날 시험인 걸 들으시고는, 시험 문제 스타일과 선지로 어떤 내용들을 냈는지 알려주셔서 크게 어렵지 않았습니다. Spinal cord 손상 환자는 일반 환자와 호흡에 있어서 어떻게 다른지를 강조하셨습니다.

				*23: 야마에서 선지를 변형하여 문제를 내셨다. 강의록의 내용만을 보고서는 판단할 수 없는 선지도 있었지만 수업시간에 강조하신 부분이 선지로 나와 소거법을 이용하여 풀 수 있었다. *22: 조장혁 교수님 호흡재활 파트를 이어서 맡으셨다. 야마도 없는데 강의록 내용만으로 정확히 판단할 수 없는 선지들이 많아서 어려웠다.
이희정		○	고대	*25: 1 시간 들어오셨는데도 불구하고, 전반적으로 무난했던 호흡기 2 차 시험에서 피드백 문항 3 개 중 2 개를 차지하셨습니다. 이희정 교수님은 매번 시험 하루이틀전에 들어오시는데, 양이 많고 강의록에 없는 내용들을 선지로 출제하십니다. 저희가 질환의 기본적인 내용을 전부 숙지하고 있다고 생각하시는 것 같습니다. 두 문제 모두 탈야마였으며, 수업 때 크게 강조하지 않으신 내용이었습니다. 야마는 기본적으로 다 알고 있어야 하며, 강의록을 전부 읽어보시는 걸 추천합니다. 개인적으로 영상 파트 수업들은 굿노트 스터디세트로 공부하는 방식이 도움이 되었던 것 같습니다. *23: 강의록의 사진들을 잘 기억한다면 어떤 병인지 매칭시킬 수 있을듯하다. 그러나 1 문제가 강의록에서 도저히 찾을 수 없는 내용을 정답 선지로 내셨다. *22: 역시나 PPT 사진과 병을 매치시키는 것이 중요. 야마 변형이긴 하지만 병의 특징을 자세히 알아야 맞힐 수 있는 문제가 한 문제 나왔다. *21: PPT 사진과 병을 매치시키는 것이 중요.
김진희	○		고대	*25: 강의록 내용이 워낙 많습니다. 그러나 박순호 교수님 파트와 약간 겹치기도 하고, 풀야마 태워주셨습니다. 수업 끝날 때도 어렵게 안 낸다고 하셨습니다. *23: 야마의 문제들에 약간의 선지 변형만 추가하여 문제를 내셨다. 선지 분석을 했었다면 충분히 풀 수 있는 문제들이었다.
김미애		○	22~	*25: 야마를 극히 일부 타시기도 하지만, 강의록 내용을 꼼꼼하게 공부해야 풀 수 있는 문제가 대부분이었습니다. 전형적인 소견과 치료만 대입해서 생각하기에는 어려운 문제들이 많아 피드백(정답률 50% 미만) 9 문제 중 4 문제가 김미애교수님 문제였습니다.

				수업이 전부 온라인으로 진행되었는데, 강의록 내용을 거의 읽어주셔서 많은 동기들이 공부하는 데에 어려움을 겪었던 것으로 기억합니다. 임상 진단을 요하는 문제와 강의록 기반 내용 문제를 모두 출제하시기 때문에, 강의록 내용과 KMLE 를 모두 꼼꼼하게 보시는 것을 추천합니다. *23: 야마를 안타십니다. 하지만 수업시간에 강조하신 표에서 출제하셨고 문제도 매우 쉽게 내시니 강조하신 부분 위주로 참공하시면 될 듯합니다. 천식과 COPD 파트를 수업하시는 데, KMLE 가 도움이 되었습니다.
김가은			23~	*25: 풀야마였습니다. 전부 온라인 수업으로 하였고, 이전 가이드라인에는 야마 안타는 문제도 있으니 빨간색 텍스트 위주로 참공해야 하는 부분도 있다고 되어 있었고 양도 적지 않은 편이라 다들 긴장했으나, 풀야마여서 쉽게 풀고 나왔습니다. Kmlle 안 풀어보셔도 될 것 같습니다. *23: 총 4 시간의 수업으로 내용이 상당히 많았다. 시험에서 8 문제를 내셨는데 6 문제는 야마와 거의 동일하게, 나머지 2 문제는 참공부가 필요한 문제로 나왔다. 하지만 그 2 문제도 교수님께서 강의록에 붉은 글씨로 표시해주신 부분을 바탕으로 풀 수 있었으므로 붉은 글씨들을 중점으로 참공부가 필요할 듯하다. (야마의 선지들도 붉은 글씨와 거의 동일했음.)
홍정희			23~	*25: 풀야마입니다. 설명은 잘 하시는 것 같지만, 말이 엄청 빠르시고 수업을 항상 빨리 마쳐주십니다. 영상 파트가 워낙 어렵다보니, 강의록 말고 야마만 보고 시험장 들어가는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다. *23: 올해 새로 들어오셨는데, 시험 보기 전에 기출문제들과 사진 잘 보라고 말씀해주셨습니다. 기존 이진희 교수님 문제 에서 선지만 변형되어 출제되었습니다.
송봉일			20	*25: 김해원 교수님 대신 들어오셨습니다. 이전 과목까지는 김해원 교수님이 사용하시던 강의록을 아주 약간만 변형해서 사용하셨는데, 이번에는 새로 강의록을 들고 오셨습니다. 그러나 AI 에게 부탁해서 만든 강의록이었어서, 교수님께서 수업 때

				강조하시는 내용과 마지막에 요약정리해주시는 내용만 알면 시험 문제는 쉽게 풀렸었습니다.
김해원				*25: 안 들어오심. *23: 강의시간에 들어오셔서 시험 문제를 어디서 내실지를 다 알려주셨다. *22: 수업시간에 문제 나오는 곳을 다 짚어주셨다.
이진희			20'~	*25: 안 들어오심 *23: 안 들어오심 *22: 전년도와 동일 *21: 양도 많고 꽤 어렵다. 영상파트이기 때문에 이 강의만 듣는다고 다 알기는 어려움. 다른 교수님들 강의에서 각 질 병에 대해 배울 때 먼저 영상도 같이 잘 봐두고 이 파트를 복습하는 느낌으로 나중에 공부하는 걸 추천.
권용식	○		19'~	*25: 안 들어오심 *23: 작년과 마찬가지로 한 두문제(변형) 제외하고 야마 그대로 타십니다. *22: 1~2 문제 제외하고 거의 다 야마와 동일하게 출제 *21: 강의록이 상당히 많으나 항상 나오는 곳에서 거의 출제 되기 때문에 야마에 나온 파트 중심으로 공부하는게 좋다
김진영	○		18'~	*25: 안 들어오심 *23: 절반 정도는 야마 타시고 나머지는 야마 안타십니다. 강의록에 실린 사진을 그대로 사용하시므로 강의록 사진 위주로 공부하시면 좋습니다. *22: 영상. 무난하다. 야마 선지 분석하기
최희정	○		19'~	*25: 안 들어오심 *22: 야마 어느정도 태워주셨고, 지엽적인 선지 잘 판단해야 함. 폐렴 구분할 수 있어야 한다. *구 가이드: 수업 중 강조 + 야마 + KMLE

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	순환기		학점	5 학점
과목 요약	첫 2 주 동안 기초의학, 진단검사, 영상, 심전도 등을 공부하고, 그 다음 3 주간 순환계에 관련된 질병을 중심으로 배운다. 각 시험 보기 전에, 공부를 하며 몰랐던 부분을 질문할 시간이 예정되어 있고, 시험 본 후에는 피드백 수업을 하며, 학생들과 소통을 위해 많은 노력을 하신다. 늘 봐오던 X-Ray 나 CT 영상 뿐만 아니라 초음파, 심전도 등 다양한 검사와 영상이 나오기 때문에 어렵고, 5 주 블록이기 때문에 공부량이 많으며, 호흡기 과목보다 야마의 비중도 감소한다. 하지만 차분히 공부하다 보면 무난히 지나갈 수 있으니, 수업 열심히 듣고 포기하지 말자. 아직 임상의학 공부가 어색해, 공부 방향에 여러 시행착오를 겪는 시기이다. 순환기 2 차 시험의 경우 판막마다 질병의 특징이 다르고, 혈관 파트와 소아 파트도 양이 굉장히 많다. 때문에 엉뚱한 부분을 중심으로 공부를 하거나, 머릿속에서 공부 내용끼리 섞여 시험장에서 멘붕이 올 수 있다. 이런 일을 예방하기 위해서는 수업을 들은 후나 듣기 전에 꼭 야마를 보면서 어느 부분이 중요하고, 교수님께서 어떤 유형으로 출제하는지 확인한 후, 이 부분들을 중심으로 공부하는 것을 추천한다... KMLE 도 도움이 된다고 한다.			
올해 경향	✓ 강의록 양이 많지만 임상 교수님들은 대부분 야마 타시는 편이니 야마를 중심으로 내용을 정리하면 도움이 된다. ✓ 해부학을 김태영 교수님 혼자서 전담하는데 임상 교수님들의 강의록이 더 이해가 잘 되니 함께 공부하는 것이 도움이 된다. ✓ 간혹 KMLE 에 더 잘 정리가 되어 있는 경우도 있으니 참고할 것			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
김태영			25	*25: 잘 아시겠지만 수업도 시험도 많은 오류가 있으시다. 특히 수업시간에 출제하지 않을 것이라고 얘기한 부분에서도

				출제하시고, 중요한 내용이 무엇인지 따로 강조하지 않으므로 고등학교 내신 공부하듯이 꼼꼼하게 공부해야 한다...
이현수		O		*25: 들어오지 않으셨다. *23: 들어오지 않으셨다. *22: 기초신경 과목과 해부실습 내용을 바탕으로 문제를 출제하셨다. *21: 해부학 파트를 강의하셨고, 야마를 많이 타시지는 않았다. 3 문제는 쉽거나 특징적인 곳에서, 1 문제는 변별력 있게 출제하신 것 같다.
허유란			23	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 올해부터 이현수 교수님 파트를 맡으셨는데 수업시간에 강조하신 부분에서 모든 문제를 출제하심. 수업 잘 듣기
최인장		O	고대	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 들어오지 않으셨다. *22: 유형은 작년과 비슷하지만 지엽적이므로 꼼꼼한 공부가 필요함. *21: 조직학 파트를 강의하셨는데 야마 안탔고, 4 문제 중에 3 문제가 피드백 풀이에 나올 정도로 어렵게 출제되었다. (정답률이 너무 저조해 피드백 담당 교수님이 최인장 교수님께 다시 문제와 풀이에 문제가 있는지 검수를 부탁드립니다.) 강의록에 없는 내용도 출제되었다.
이재호				*25: 들어오지 않으셨다. *23: 수업시간에 강조하신 부분에서 출제하시고, 올해는 꼭 출제하겠다는 한 문제를 알려주심. 수업 집중해서 들으면 공부할 때 매우 편함. *21: 수업시간에 문제 알려주심

송대규		○	고대	*25: 집어주신 곳에서 아주아주 쉽게 출제하셨다. *23: LMS 에 토론과제 9 문제를 미리 내주시고 수업시간에 학생발표 형식으로 진행하심. 보충할 부분만 추가로 강의하셨음. 시험문제는 토론과제 내용에서 어렵지 않게 출제되었음. 같은 해 출제된 예과 2 학년 인구기 1 순환생리 기출문제를 보고 들어가는 것 추천. *22: 수업을 학생 발표 형식으로 진행하였음. 1 문제는 당해 예 2 시험문제와 동일하게 쉽게 맞출 수 있도록 출제되었고 1 문제는 예 2 때 배운 생리학을 바탕으로 한글 파일 그림에서 출제하심 *구 가이드: 심박출량 강의. 생리학 때와 똑같다. 수업시간에 얘기하신 부분 다 외워야 됨. 다행히 한 시간이라 양은 그렇게 많지 않음 참공부하자. but 2019 년에는 수업 중 예시로 말해주신 부분에서 나왔다. 강의록에 없는 내용은 안 나온다.
김진영 (내과)	○		18'~	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 매년 나오는 부분의 야마 선지를 변형해서 출제하심. 고대 야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 야마에서 출제된 부분이나 수업시간에 강조하신 강의록 사진을 잘 봐두어야함. *22: 강의록 그림을 꼼꼼하게 봐야한다. 기존의 야마와 같은 유형이지만 다른 그림(좌심방->우심방)으로 출제하셨다. 김진영 교수님은 2 차 순환기 시험 때 배우는 범위도 1 차 때 그냥 가르치시기 때문에 공부하는데 시간이 더 들었던 것으로 기억난다. 그래서 2 차 시험 때 배우는 질환이더라도 kmle 책을 간단히 읽어보는 것이 공부하는 데 도움이 되었다. 그리고 주관식 문제도 한 문제씩 출제하셨다. *구 가이드: 영상의학. 무난하다. 야마 선지 분석 잘하자. 2019 년에는 한 문제 탈야마 하셨다. 수업 중에 집어주시긴 했지만, ppt 에 없는 영상이어서 어려웠다. 구글에 view 검색해서 찾아보면 도움될 수도 있다.

홍정희			25	*25: 대개 전년도 야마와 거의 동일하게 출제하신다. 이번에도 동일하게 출제하셨다.
김권배			고대	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 들어오지 않으셨다. *21: 야마 선지 분석이 도움이 된다
이성용			고대	*25: 역시나 탈야마 하셨습니다. 문제 자체는 크게크게 출제하셨으나, 헛갈리게 출제하셔서 오답률이 다소 높았습니다. *23: 풀야마 타심. 고대야마까지 모아서 공부하는 것 추천. *22: 그저 빛... *구 가이드: 믿고 가자. 수업태도는 좋게~ 시험은 풀야마
장정희		O	고대	*25: 첫 번째 강의록은 약물이 많았지만 두 번째 강의 끝날 때 약물 몇 개를 집어주셨습니다. 그 약물 내에서 출제되었고 나머지 문제들도 다 평이하게 출제되었습니다. 약물별 특이 작용 기전을 공부하시는 것을 추천합니다. *23: 고대 야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 야마랑 완전 동일하게 출제하시진 않지만, 나왔던 사례를 재활용하여 종종 출제하심. YBL+참공을 해야 안전하게 다 맞을 수 있음. *22: (1 차 시험) 약마다 부작용을 잘 알고 부정맥마다 치료가 어떤 약들로 진행되는지 kmle 를 참고해서 공부해야 한다. (2 차 시험) 항상 같습니다. 강의자료에 있는 약물별 부작용을 중심으로 공부하시면 편하고, 약물마다 사용되는 상황 (chronic, acute heart failure)을 잘 알아두시면 좋습니다. *구 가이드: 야마 안탄다. 문제는 case 형식 R 형도 있음. 부작용 꼼꼼하게 외우기. 메일로 강의록을 보내주실 때가 있는데 본 1 때처럼 전원 뽑으면 된다. 수업 때 외울 약을 집어 주심. 외울 약

				외우고 야마 문제 보고 어떤 때 어떤 약 쓰는지 확인. 부작용 꼼꼼히 외우기. 나오는 약들이 계속 나온다.
이지선			25	*25: 강의력이 좋으셔서 공부하기 수월한 편이다. 문제는 강조하신 부분에서 대부분 출제하신다.
박성균	○		20'~	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 풀야마 타셨는데, 야마 선지 약간 변형하심. 수업시간에 강조하신 부분에서 모두 출제. *22, 21: 야마 타셨다.
강혜인			25	*25: 야마와 비슷하게 내시며, 수업시간에 출제한 부분을 확실히 집어주신다.
박형섭	○		12'~	*25: 역시나 풀야마. *23: 풀야마 타심. 고대 야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 강의록의 특징적인 심전도를 잘 봐두면 쉽게 풀 수 있음. *22: 거의 ppt 에 있는 그림 출제하셨으며 간단한 특징만 알아 도 맞출 수 있게끔 출제하셨다. 2022 순환기 1 차 35 번 문제처럼 심전도 배운 것을 종합적으로 생각할 줄 알아야 하는 문제 도 출제하신다. *구 가이드: 깔끔한 강의. 18 년에는 심전도 총론을 맡으심. 판서로 열강해주신다. KMLE 도움되고 옛날 본인이 심전도 파트 맡으셨을 때 냈던 문제 나왔다. 심전도라 이해는 어렵지만, 문제는 단순한다. 책에 있는 심전도를 주고 질환과 매칭하는 문제. 이해가 안되면 심전도 모양만 외워도 다 맞춘다.
장우성			16'~	*25: (1 차) 수업은 시간을 꽉꽉 채워서 하시지만 문제를 어렵지 않게 출제하신다. 굉장히 기본적인 내용이므로 수업을 잘 들어두면 뒤쪽 공부를 할 때 도움이 될 것이다.

			(2 차) 3 문제는 야마, 1 문제는 새로 출제하셨습니다 그마저도 매우 평이하게 출제되었습니다. 야마 위주로 공부하시는 것을 추천합니다. *23: 들어오지 않으셨다. *22: (1 차 시험) 심장 외과학 총론은 수업시간에 집어주신 것을 바탕으로 쉽게 출제 (2 차 시험) 외과 파트인데 청색증/비청색증형 선천심질환의 수술적 치료를 강의하시니 소아 파트와 서로 참고하며 공부하시면 좋을 것 같습니다. *21: 야마는 타지 않으셨으나 강의록 퀴즈를 문제로 출제하셨음. 강의록 기반으로 참공부 해야 될 것 같습니다...
조윤경	O	12'~	*25: 강의력이 아주 좋으시며 야마도 타시는 최고의 교수님. 1 차 강의 내용은 낯설고 어려울 수 있으나 1 차 후반부 강의를 듣고 다시 공부하면 잘 이해가 될 것이니 걱정하지 말 것. *23: 야마 변형을 많이 하시는 편. 빈출되는 야마 유형으로 거의 출제하시니 고대야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 야마 내용 공부할 때, 한글 파일 강의록도 꼭 같이 공부하기. *22: 1 차 시험에서는 야마를 타셨지만, 2 차 시험에서는 그냥 정직하게 공부해야 했다. *21: 야마에서 출제된 부분에서 약간 변형하여 내시는 경우가 많아 야마에서 출제된 부분을 강의록 기반으로 공부하면 좋을 것 같다. *구 가이드: 깐깐하신 편이지만 18 년에는 수업태도가 좋아서 (대답을 매우 잘했음) 대놓고 좋아하셨음. 17 년에는 수업 시작 할 때 분위기 안 좋아서(떠들어서) 마치고 PPT 도 안 주셨지만 18 년에는 상당히 조심해서 PPT 도 주시고 가셨음. 수업 태도 매우 중요. 대답 잘하고 지각/결석/졸음 금지. 시험 내는 부분 을 집어 주신다. 야마도 그와 비슷. 중요한 것 밑에 항목이 많이 있는데 뭐가 어떻게 나올지 모르니 꼼꼼히 다 외우기.

황종민	○		19'~	*25: 야마 타심 *23, 22: 야마 타심 *21: 야마 타주시고 전반적으로 내셨던 부분에서 반복적으로 내주시는 것 같아 야마에 나온 부분을 공부하는 것이 좋을 것 같다. *구 가이드: 19 년도에 새로 오심. 강의록으로 수업. 해리슨 있으면 좋음. 문제스타일을 정립하는 중이라 매년 바뀔 것 같다. 2019 년 출제 방식은 집어 주신 것 안에서 한 글자씩 바꿔 서 선지를 구성하셨다. 강의록 말을 그대로 긁어 오심. 수업 중에 중요하다고 하신 것들을 꼼꼼히 외우자.
정진욱	○		19'~	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 풀야마 타심. 다만, 심초음파 개론 파트를 수업하시기 때문에 들어두면 심초음파 이해에 도움됨. *22: 야마 많이 타셔서 쉬웠다. 2022 1 차 46 번 한 문제만 1 차때 안 배운 심장눌림증을 출제하셔서 2 차 범위까지 다 배우고 보니 쉬웠지만 시험 칠때는 어려웠다 *21: 1 차에서만 들어오셨고 심초음파를 들어오셨음. 역시 야마 잘 태워주셨다.
김형섭	○		고대	*25: 올해는 원래 출제하신 느낌과 다르게 학생들의 편의를 많이 봐주셨습니다. 중증 기준만 잘 알아달라고 언급하셨고 실제로 문제도 중증 기준으로만 4 문제 출제하셨습니다. *23: 대놓고 야마를 탔다는 느낌은 안 들지만, 야마 변형 출제하심. 고대야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 교수님께서 강의록(한글 파일)에서 꼼꼼하게 출제하심. *22: 판막질환을 강의하시는데, MS MR AS AR 에서 한문제씩 내십니다. 한글 파일로 수업하셨는데 수업하면서 pdf 에 하이라이터로 표시하시는 부분이 중요한 부분이고, 중증 기준은 완벽하게 아셔야 합니다.

				*21: 야마 어느정도 타셨지만 2 차에 오답률이 매우 높았던 문제가 하나 나왔었다. 적당히 자주 내시는 파트 외워주는 것이 중요할 것 같다.
한성욱	O		14'~	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 명강의지만 내용은 어려워 이해하려면 여러 번 복습하면서 공부해야 함. 시험문제는 모두 야마와 동일하거나 변형이었음. 고대 야마까지 모아서 공부하는 것 추천. *21: 기존에는 심전도 그래프만 외우면 되는 식으로 문제를 출제하셨으나 21 년도에 완전히 탈야마를 하셔서 R 형 문제로 치료법을 많이 출제하셨다. 앞으로는 어떻게 나올지 모르니 kmle 도 함께 보는 것이 이해에 도움이 될 것 같다. *구 가이드: 심전도. 노트북으로 강의하셔서 녹화도 안 된다. 17 년도부터는 심전도 수업 전에 교수님께서 셀프 녹화하신 강의 파일을 미리 홈페이지에 올려주심. 심전도 수업이라 매우 어렵고, 이해하기도 어려움.. 다만 문제는 PPT 의 심전도가 그대로 나와 풀 수는 있었다. Case 문제도 있었다. 19 년도에 1 교시 수업 때 10 분 일찍 오셔서 애들 없다고 뭐라하심. 수업이 방대하지만 명강의여서 다른 수업 2~3 배정도 잡고 공부하면 다 이해할 수 있다. 2019 년에는 2018 년 문제로 풀야마타심.
정태완			25	*25: 처음 들어오신 교수님. 학생들에게 전공의에게 설명한 자료로 수업하셔서 다들 당황했었음. 그러나 시험 문제는 야마 + 수업시간에 보여준 문제 + 그리고 그 문제 변형이라 많이 어렵지 않았음. 수업시간에 보여준 문제와 그에 해당하는 내용 확실히 공부하고, 야마도 풀면 충분히 풀 수 있는 문제였다. KMLE 내용 참고하면 더 이해하기 쉽다!!

원경숙	O		고대	*25: 문제가 어렵진 않았으나 강조한 데에서 출제하지는 않으신다. 수업 열심히 들은 후 강의록을 꼼꼼하게 보는 게 좋을 것 같다. *23: 2 문제 출제하시는 것에 비해선 강의록 양이 많음. 비용효과 분석에 관한 문제는 야마를 탔지만, 풀려면 강의록을 꼼꼼히 알아야 하고 다른 한 문제는 상대적으로 덜 강조하신 부분에서 출제되었으니 수업을 꼼꼼히 들어야 함. *22: 전체적인 내용은 야마를 타셨지만 시험 문제는 상당히 헛갈렸다. 특히 비용 효과적인 적응증을 고르는 문제를 풀기 위해서는 수업을 잘 들어야 한다. *21: 야마를 적당히 타주시지만 강의록에 있는 내용으로 나오니 강의록 기반으로 공부해주시는 것이 좋을 것 같다. *구 가이드: 양이 적어서 할만 함. 야마 적당히 탄다. 중요한 게 중요한 것. 2019 에는 수업 중 quiz 내신 것에서 한 문제 나옴 (탈야마문제)
김인철	O		17'~	*25: (1 차) 대개 야마를 타시며 조금 변형하시는 편. 수업시간에 강조한 내용에 대해서만 출제하시기 때문에 어려운 내용에 비해 문제가 많이 어렵진 않다. 강의력도 좋으시고 판막 질환은 2 차 때도 거의 동일한 내용이 나오므로 잘 들어두면 도움이 될 것이다. (2 차) 풀야마입니다. 선지가 수정된 몇몇 문제가 있으나 야마 문제와 거의 동일합니다. 수업 내용이 어렵지도 않고 수업도 쉽게 진행하십니다. *23: 해외연수를 가셔서 들어오지 않으셨다. *22: 수업 시간에 강조하시는 부분과 야마가 동일합니다. Myxoma 는 꼼꼼히 보세요. *21: 심초음파와 심장이식은 야마에서만 출제되었다. 주관식으로 출제하는 문제가 있어 야마임에도 정답률이 낮은 경우가 있습니다. 심장종양은 강조한 내용과 중심 내용에서 출제하셨습니다. 양이 많긴 하지만 야마를 많이 타고

				중심내용과 강조한 내용 위주로 보면 어렵지 않게 넘길 수 있습니다. *구 가이드: 명강의. 문제를 영상으로 내셨는데, 수업시간에 다 보여주심. 무난 강의록은 많으나 수업은 일부만. 풀야마. 심장이식은 야마가 적다. 하지만 집어주심.
이선화	O		23	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 올해 김인철 교수님 파트를 대신 수업하셨다. 풀야마
황일선	O	O	12'~	*25: 올해 황일선 교수님께서 담당하신 호흡기, 순환기 수업은 모두 TBL 방식이었습니다. 순환기 TBL 은 올해가 처음이었는데 모든 문항을 수업 시간에 진행한 TBL 문항과 동일하게 출제하셨습니다. TBL 문항과 병리학 교과서를 참고하면 좋을 듯 합니다. *23: 수업 중 실시한 LMS 형성평가 문제에서 동일한 문제(대동맥박리)가 시험에 출제되었음. 시험문제들이 수업시간에 강조하신 부분에서 쉽게 출제되었음. *22: 항상 같습니다. 병리학 교과서에서 문장 그대로 출제하십니다. + 22 년 시험에는 사진이 출제되었는데 강의자료에 있는 사진과 동일했습니다. *21: 원래 야마를 많이 타는 교수님이셨는데 19 학번때는 탈야마 많이 하셨습니다. 가끔씩 주관식도 내시니 질환의 명칭을 외우는 것도 중요한 것 같습니다. 병리학 책의 한 부분을 그대로 가져와 문제와 선지를 만드니 책을 참고하는 것도 좋습니다. 딱히 어느 부분을 강조하지는 않으시지만 해당 질환에 구체적인 특징을 알아야 문제를 풀 수 있어 구체적인 수치나 병의 진행 단계 등을 외워가며 자세히 공부해야 될 것 같습니다.
허승호	O		고대	*25: 들어오지 않으셨다.

				*23: KMLE 도움 됨. 야마 일부 타셨고 출제하실 문제 수업시간에 일부 알려주심. *22: 운동부하검사 꼼꼼히 공부하시고, angio 보고 관상동맥 원지 판단해서 PCI 와 CABG 중 선택할 수 있어야합니다. *21: 강의록에 있는 퀴즈문제에서 변형하여 내는 문제들이 있으니 퀴즈 내용 자세히 보고 주변 내용들 숙지하는 것이 중요할 것 같습니다. 내용이 많지만 야마 타는 문제도 있으며 지엽적인 문항도 물어봅니다. *구 가이드: 예의 중요시하니 주의하자!! 16 년에는 몇 명 지각 했더니 소리지르셨다 한다.. 시험은 무난하다. 야마 잘 보고 수업 중 강조하시는 파트. 마지막에 집어주시기도 함.
남창욱	○		고대	*25: 이전에도 출제하시던 내용을 기반으로 문제를 출제하시지만 몇 개는 변형하여 출제하십니다. 복잡한 내용을 잘 풀어서 설명해 주시는데, 강의록 내용이 전부 영어라 한글로 내용이 잘 정리된 KMLE 를 참고하는 것도 좋을 듯 합니다. 중요하다고 강조하시는 내용이 야마로 출제된 적이 있기에 야마에 출제된 내용을 잘 정리하면 좋을 것 같습니다. *23: 시험문제가 야마와 거의 동일하다고 느껴지지만 생각보다 변형 많이 하심. 고대야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 수업이 깔끔하시고 도움 많이 되었음. 수업시간에 무슨 파트에서 문제 출제하겠다 알려주셨는데 그 파트 주위로 조금 더 공부하는 것이 안전함. *22: 절반은 야마를 타고 절반은 야마를 타지 않으시지만, 수업 중에 강조하신 부분에서 나왔습니다. 알면 알고 모르면 모르는 내용이라 수업을 잘 들으시고, 흉통을 감별하는 것도 강조하시니 이 부분은 KMLE 나 KMLE 끝자락의 R type 문제도 참고하면 좋은 공부가 될 듯합니다. *21: 굉장히 중요한 파트, 수업도 재미있습니다. KMLE 에서 관련된 내용이 나오니 KMLE 보는 것 중요한 것 같습니다. 문제가 생각할 거리가 많으니 꼼꼼히 푸는 게 중요한 것 같습니다. 야마는 조금 타고 강의록에 있는 참고문제를

				변형해서도 내니 참고문제와 야마를 꼼꼼히 보는게 중요할 것 같습니다.
이철현	○		18'~	*25: 풀야마 타셨습니다. 강의들을 땀 공부 어떻게 할지 막막했지만 빨간별 부분에서 다 출제하셨고 그마저도 야마였습니다. 야마 위주로 공부하시는 것을 추천합니다. *23: 대부분의 문제를 PPT 에 빨간 별을 해놓은 부분에서 출제하시고 야마 많이 타셨음. 한 문제 정도가 야마가 아닌 새로 출제된 문제였는데 빨간 별 있는 부분이 아니었음. 수업은 잘 집중해서 들어보시길.. *22: PPT 에 빨간색 별이 있는 슬라이드는 무조건 아셔야 합니다. 수업 들을 때는 혼란스러운데 문제는 빨간색 별에서 내시거나 수업 중 강조한 부분에서 내시고, 야마도 적당히 태워주십시오. 정리자 개인적인 의견으로는 심부전 파트는 KMLE 가 도움이 되었습니다. *21: 피피티 양이 매우 많지만 시험엔 나올 부분은 빨간색 별표로 집어 주십시오. 빨간색 별표 쳐져 있는 부분과 야마를 중심으로 공부하는게 좋습니다.
최희정	○		19'~	*25: 양이 매우매우 많습니다. 안그래도 시험 직전 수업이라 촉박해서 더욱 힘들었던 기억이 있습니다. 대체로 야마 타시고 2 문제 정도 탈야마 하셨습니다. 하지만 참공은 매우 힘들기 때문에 야마 선지만이라도 다 정리해서 공부하시는 것을 추천합니다. (야마 선지만 정리해도 다른 강의록 공부할 만큼의 양이 나옵니다.) *23: 풀야마 타심. 고대야마까지 모아서 공부하는 것 추천. *22: 소아 파트입니다. 작성자 개인적인 의견으로는 KMLE 가 나름 도움이 되는 것 같습니다. 야마도 적당히 태워주십시오. *21: 소아과, 수업은 재밌으나 소아과라서 내용이 좀 생소한 편입니다. 21 때 나온 문제들을 보면 질환을 진단하거나 질환을 추론하게 하고 이에 대한 치료를 묻는 문제였습니다. 그래서

				질환의 증상과 치료 위주로 공부하는게 좋을 것 같습니다. 야마도 꽤 타는 것 같습니다.
김재현	O		14'~	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 들어오지 않으셨다. *21: 내용은 많으나 야마를 그대로 내시거나 약간 변형해서 내십니다. 야마에서 나왔던 슬라이드들을 자세히 공부하는게 좋을 것 같습니다. *구 가이드: 흉부외과 교수님. 시험 전전날이라서 마칠 때 다 집어 주셨음 + 야마. 2019 년에 야마가 조금 변형됨. 따라서 강조하신 슬라이드는 꼼꼼히 다 외우자!
윤혁준	O		고대	*25: 원래 담당하셨던 고혈압과 이전에 허승호 교수님께서 담당하셨던 안정형 협심증을 담당하셨습니다. 고혈압은 절반 정도는 비슷한 문항을 출제하시는데 절반은 새로운 문항을 출제하십니다. 안정형 협심증은 예전 교수님 강의록을 그대로 사용하여 수업하셨지만 모두 새로운 문제를 출제하셨습니다. 쉬운 개념부터 특정 약물을 사용하지 않는 이유와 같은 자세한 내용까지 출제하셨습니다. 중요 내용을 정리해서 공부하는 것이 도움이 될 것 같습니다. *23: 수업시간에 강조하신 부분을 위주로 출제하셨지만 고혈압 파트에서 크게 강조하지 않은 고혈압성 응급에 관한 내용을 출제하여 많은 동기들이 당황했었음. *22: 강조하신 것을 모아 공부하면 효율적으로 공부할 수 있습니다. 여러가지 표를 강조하시는데 몇 문제 살린다 셈치고 꼭꼭 외우고 들어가세요! (특히 상황별 사용하는 약물) *21: 수업시간 증례 + 야마. Kmle 도움
이희정			25	*25: 올해 새로 들어오셨습니다. 강의를 매우 잘하십니다. 강의록 자체엔 없지만 교수님 수업 PPT 엔 빨간색으로 표시된 부분이 있습니다. 강의록당 4 개 정도 있고 그 중 2 개를

				출제하십니다. 양이 방대하지만 표시된 4 개 중에서 출제하시니 그 부분을 정확히 공부하시는 것을 추천합니다.
박남희			고대	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 수업시간에 출제하실 부분을 알려주셨음. *22: 수업 시간에 강조하고 집어주신 부분에서 출제하십니다. *21: 수업시간에 풀어보라고 하신 예제 + 야마 *구 가이드: 순환기학 책임 교수님. 친절하신 분이니 예의 바르게 하고 수업태도 조심, 수업 중 집어 주신 것 & 야마 분석 *구 가이드: 매우 방대한 양을 줄줄 읽고 가셨지만 예상을 깨 고 전부 야마 탔다. 를 믿었는데 18 년에 탈야마 하심.. 19 년도 문제는 아주아주 쉽고 간단하게. Kmle 도움. 같은 답이 여러 번 나와도 흔들리지 말자.
김윤석	○		19'~	*25: (1 차) 수업시간에 설명하신 내용에서 출제하신다. 문제가 어렵진 않은 편이나, 강의록은 전년도와 달라 야마를 타진 않으셨다. (2 차) 풀야마 타셨습니다. 강의시간에 중요하다고 언급하신 부분도 야마와 일치했습니다. 야마 위주로 공부하시는 것을 추천합니다. *23: 풀야마 타심 *22: 수업 시간에 잘 보라고 이야기하신 부분에서 출제하셨습니다 *구 가이드: 무난하게 수업하시고 마지막에 문제 집어주심. 그리고 내던 곳에서 내겠습니다. 하시고 풀야마.
송경섭				*25: 수업을 매우 잘하시고 수업시간에 중요하다고 언급하신 부분에서 다 출제되었습니다. 강의를 들으면서 공부가 다 되어 따로 공부할 필요가 없었습니다.

박의준	○		고대	*25: 들어오지 않으셨다. *23: 풀야마 타심. 고대야마까지 모아서 공부하는 것 추천. 원래는 2 차 범위에 들어가는 내용이었으나, 대체공휴일 때문에 1 차에 포함된 범위. 교수님 수술 일정 때문에 수업에 늦게 들어오셨다고 기출문제에서만 출제하겠다고 미리 알려주셨음. 고대야마에 노영남 교수님 파트와 겹치는 부분이 있어 같이 공부하는 것 추천. *22: 원래 혈관질환은 동맥파트, 정맥파트로 나뉘는데, 박의준 교수님께서 정맥파트만 말씀하다가 동맥파트도 말씀했고, 당시 강의록도 주시지 않아서 많이 혼란스러웠음. (강의자료 엄청 용량 커서 다운로드 오래걸리니까 선배 필기 미리미리 다운받아둡시다.) 수업 중간중간에 동기들한테 질문하는 것이 곧 강조사항이라고 생각하시면 될 듯합니다. 수업 시간에 시험문제를 다 집어주셨습니다.
조원현			25	*25: 올해부터 처음 들어오셨습니다. 4 시간 수업을 담당하셔서 강의록 양도 많았습니다. 실제 문제는 중요한 개념을 위주로 출제되었지만 정답 선지에 '이상 모두'가 포함되어 있어서 정답을 고를 때 헷갈렸습니다. (복기된 7 문제 중 3 문제가 피드백 문항이었습니다.) 수업 자체가 어렵지 않았지만 야마가 없어서 준비하기가 더 힘들었습니다.

본과 1 학년 가이드라인					
과목명	소화기(1)			학점	3 학점
과목 요약	KMLE 큰 도움되고, 학점이 크니 백공. 야마 많이 타고 수월하다. 동기들 간의 편차가 적음. 18 년 1 차 평균이 82.4 점 최고점수 93.1 / 2 차 평균 88 최고점수 98. 19 년도에는 편차도 꽤 나고 문제도 18 년도에 비해 어려웠다. 시간당 2 문제.				
올해 경향	위장관 파트, 3 주, 시험 1 번, 시간당 두 문제(90 문제), 재시 O(본시 그대로 45 문제) 야마, KMLE, 야마 그대로 출제되는 문제들이 매우 많았다. 25 : 일단 시수가 많아서 쌓이면 무섭습니다. 야마 있으신 분들은 야마를 대체로 좀 타셨던 것 같고, 새로 들어오신 교수님들 혹은 새로 맡으신 파트들도 크게 어렵지 않게 내셨거나 수업 시간 때 강조해주신 파트에서 내셨습니다. 김태영, 조광범 교수님을 주의하시면 됩니다.				
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향	
	YBL	안탐			
기초					
배재훈			고대	*25 : 한글 강의록으로 수업하시는데, 양이 꽤 많습니다. 야마는 절반 정도만 탔던 걸로 기억하며 배재훈 교수님은 늘, 언급하지 않고 지나간 부분에서도 시험문제를 내시기 때문에 문제를 전부 맞히려면 강의록도 전부 보셔야 합니다. 그래도 수업 때 강조하시는 건 문제로 내시는 편이니 수업을 잘 들으시면 좋습니다. 배재훈 교수님 파트는 기종평을 꼭 다 보시고 들어가시는 걸 추천드립니다. *23: 작년과 비슷합니다. *22: 기종평 문제에서 자주 출제하시므로 교수님께서 기종평 수업하신 파일을 받아 공부하는 것을 추천 드립니다. *구 가이드: 본 1 생리학 문제 보면 큰 도움 된다. 수업은 항상 명강의. 수업 태도 조심. 지각하면 안 됨 +) 각종 구야마	

				기종평 드라이브의 추가 문제 등 많이 볼수록 도움되는 다다익선 공부법 하시면 좋습니다
김태영			25	25 : 야마가 없는데 6시간이나 들어오셨고, 강의록을 쪽 읽으셔서 다들 소화기 시작부터 힘들었습니다. 수업 중간에 시험 낼 수도 있다고 말씀하신 부분이 조금 있지만 많지가 않아서 공부할 때 어려움이 많았습니다. 문제는 사진은 없었으며 너무 지엽적이지 않고 전반적으로 쉽게 내셨습니다. 다만, 표현이 이상한 선지들이 꽤 있어서 시험 도중에 2-3문제 정도 수정되었으며 한 문제는 시험 이후에 복수정답 처리되었습니다. 중요한 내용 위주로 공부하시는 걸 추천드립니다.
신형찬			19'~	*25 : 항상 학생들을 배려해주시는 교수님. 5 분 늦게 들어와서 5 분 일찍 마쳐 주십니다. 이번에도 강의 중에 빨간색 글씨로 중요한 부분을 표시해 주셨고, 그 부분만 시험에 출제되었습니다. 강의만 잘 들으면 됩니다. *23: 수업 끝나고 시험문제가 나올 파트를 알려주시고 사진도 강의록 사진 그대로 나옵니다. 빨간색 표시만 내니까 오답이 아예 없다고 올해부터는 빨간색을 없애셨습니다... *22: 빗형찬 교수님. 강의록에 빨간색으로 강조하신 내용에서 출제할 것이라 말씀하시며, 실제로도 그렇다. 그리고 야마와도 같다. 복기된 문제는 없지만 풀야마였음. *21: 병리과 교수님, 개인적으로 수업은 재밌는 편 강의록을 보면 빨간색으로 강조된 부분이 있는데 거기서만 문제를 출제하신다. 강의록에 있는 사진을 그대로 시험에서도 사용하시니 강조된 부분과 연관된 사진이라면 기억하기.
이재호				*23: 안들어오심 *22: 의학인문학 강의로 진행하셔서 시험에 문제를 출제하지 않는 대신 과제로 대체하셨다. 속담이나 기사, 문학 작품, 드라마, 영화 등 인문학적인 요소에서 소화기와 관련된
				내용을 찾아 게시판에 올리고 댓글을 다는 식의 과제였다.

이현수				*23: 작년과 비슷합니다. *21: 이현수 교수님의 문제는 강조하시는 부분을 참공부하면 어렵지 않게 풀 수 있을 정도의 난이도로 출제되고 조직의 대표적인 사진이나 장기들의 위치관계등을 정확히 알지 못하면 헛갈리는 문제를 종종 출제하시니 기초적인 부분을 확실히 공부해두면 좋을 것 같습니다
이혜원			17'~	*25 : 이혜원 교수님께서서는 어느 과목이든, 한 문제 정도 빼고는 야마 or 야마변형으로 내시는 편입니다. 강의록 양이 워낙 많지만 야마 위주로 보시면 되고, 수업 다 하시고 마지막에 요약해 주시는데 시험 문제는 대부분 거기서 내십니다. 강의록 사진을 그대로 사용하시는 편입니다. *23: 작년과 비슷합니다. *21: 이혜원 교수님의 문제는 대부분 야마 혹은 야마변형으로 출제되었습니다. 야마 선지 분석을 꼼꼼하게 하면 어렵지 않게 풀 수 있었습니다
최인장				*23: 작년과 비슷합니다. *22: 해부 문제는 시간 나면 기종평문제를 보는 걸 추천 드립니다. 생소한 문제는 대부분 기종평 해부에서 가져오심 *21: 최인장 교수님의 문제는 아시다시피 야마를 타는 편이 아닙니다. 그래서 강조하시는 부분과 야마에 출제되었던 부분을 중심으로 참공부하는 것을 추천 드립니다.
이성용	○		고대	*25 : 이전 가이드라인들이 대체로 야마 잘 타시고 갯이라고 되어 있어서 가볍게 공부했다가 소화기(1) 때 다들 낭패를 봤던 기억이 있습니다. 대부분 야마 많이 변형 혹은 탈야마라고 생각하시고 좀 빡세게 준비하시는 걸 추천합니다. 녹화에 예민하시니, 이성용 교수님 수업만큼은 녹화를 끄시는 게 좋습니다. *23: 언제나처럼 야마 타셨던 것 같습니다. *22: 대부분 야마 그대로였고, 변형된 문제도 있었다. 야마에 출제되었던 내용만이라도 잘 봐두면 충분할 듯. *21: 풀야마, 매년 문제가 거의 똑같이 나온다. 아주 가끔 처음 보는 문제가

				나오지만 그것마저 고대야마다. *구 가이드: 믿고 가자. 19 년에는 문제가 시수에 비해 더 많이 나왔는데, 굉장히 쉬웠음.
임상				
금동윤			고대	*25 : 강의력 좋으시고, 종종 중요한 부분 강조도 해주십니다. 문제도 거의 야마 부분에서 출제하시기 때문에 야마 부분 잘 보시면 좋을 것 같습니다. *23: 작년과 비슷합니다. *22: 야마 중심으로 꼼꼼하게 보는 걸 추천. *21: 야마를 1 문제 정도 타며 수업 중에 중요하다고 한 부분을 자세히 보자! *구 가이드: 흥부외과 교수님. 17 년에 인문학 수업하셨는데 문제는 안 나옴. 18 년에 강의계획서에는 인문학인데, 수업은 식도 질환 하시고, 문제는 또 안 내심. 19 년도에도 18 과 동일하게 식도 질환 수업 후 문제는 안 내심
김미정	○		고대	*25 : 영상의학 수업을 다들 처음 들었는데, 양도 많고 말씀도 빠르시고 사진의 나열이어서 힘들었습니다. 다행히도 야마를 타시는 편이고 너무 지엽적으로는 안 내시기 때문에 야마 + 특징적인 질환의 사진들 위주로 외워 두시면 적어도 문제를 맞히는 데는 크게 어려움이 없습니다. 강의록에는 없지만 야마에만 있는 사진들도 잘 보셔야 합니다. *23: 강의록에 있는 사진이 그대로 문제로 나오기 때문에

				사진을 모두 꼼꼼히 봐 두면 좋습니다. *22: 야마 그대로 또는 변형해서 출제. 강의록에 있는 영상 사진을 주시고 병명을 물어보는 문제를 많이 내시므로 사진을 보고 질환을 감별할 줄 알아야 함. *21: 21 년 소화기 1 은 풀야마. 야마 많이 타심. 강의록에 있는 사진 그대로 시험에 사용하심. 14 년 야마와 21 년 문제의 사진이 똑같음. 사진을 똑바로 외우자
김유리			25	25 : 올해 새로 들어오신 교수님. 강의 템포가 빠르긴 하지만(근데 발음이 엄청 좋으심), 양이 많지는 않아서 따라가는데 힘들지는 않았습니니다. 수업시간에 이런 문제 내기 좋겠조? 라는 말씀을 잘 들으시면 좋습니다. 실제로 그 부분이 출제되었고, 이걸 알아 두시면 좋습니다 라고 말씀하시는 부분 역시 시험에 출제되었습니다. 강의에서 많은 힌트를 주시는 교수님입니다. 문제도 수업만 잘 들어도 맞출 정도로 평이하게 출제하셨습니다.
김정석			20'~	*23: 안 들어오셨습니다. *22: 대부분 강조하셨던 곳에서 출제하셨다. 강조하시는 내용을 꼼꼼하게 공부해두면 좋을 것 같다. *21: 오신지 얼마 안 되신 교수님이라 야마가 별로 없지만 야마를 그대로 내시는 경향이 있는 듯하다. 21 년도는 전년도 문제를 전부 그대로 내셨다! *구 가이드: 김정석 교수님은 전체 수업 중에서도 중요한 부분에 해당하는 내용 슬라이드 한 두개에서만 문제를 출제하시는 것 같습니다. 자잘자잘한 것들 보다는 큼직큼직한 내용에 초점 맞춰서 보시고, 문제에 환자 증례도 강의록에서 거의 그대로 내시니 까 쉽게 내시는 편 같아요(김우림 선배님)

류승완			고대	*25 : 강의력은 매우 좋습니다. 유머도 있으시고 학생들이 질려하지 않게 수업 잘 하십니다. 강의록을 보면 어떻게 공부해야 하나 생각이 들었지만, 거의 야마에 출제된 부분 위주로 출제하시기 때문에 야마 부분만 꼼꼼히 봐도 될 것 같습니다. *23: 야마 변형이긴 한데 주제만 겹치고 선지나 풀이 방향은 많이 바꾸셔서, 어려워하는 학생들이 많았습니다. 야마에 나오는 강의록 부분을 모두 폭넓게 보는 게 좋을 것 같습니다. *22: 강조하신 곳 or 야마에서 대부분 내주심 *21: 야마를 절반정도 타시고 안 탄 문제는 강의록을 잘 봐야합니다. *구 가이드: 수업태도 조심
박경식			고대	*23: 강의록에 예시로 나온 문제들을 잘 봐 두면 도움이 됩니다. *22: 환자 케이스를 주고 치료방법 또는 시행해야 할 검사를 묻는 문제로 대부분 출제하셨다. KMLE 방식. 케이스를 보고 무엇이 필요한지 추론할 수 있도록 공부하는 것이 필요할 듯. *21: 야마 반정도 타시고 안 탄 문제도 쉽게 내 주신다. KMLE 풀어보면 도움될 듯. *구 가이드: KMLE 꼭 풀기. 양 많다. 그렇지만 수업 열심히 듣고 강의록 열심히 보면 됨. 수업 시간에 국시문제 풀어주심
				18 년도에 내시경 수업하신 걸 19 년도에는 이주엽 교수님이 수업하셨음.
배성욱			14'~	*23: 작년과 비슷합니다. *22: 강의록 쪽수는 적었으나 설명을 굉장히 길게 하셨다. 13 쪽으로 강의 시간을 다 채우셨음. 복기된 문제가 없는 것으로 보아 야마 그대로 타셨던 것 같다. *21: 기억이 잘 안 난다... 21 년에는 쉽게 내셨음 매년 똑같이 내시는 문제가 하나 있음

백성규			고대	*25 : 갓갓 교수님. 야마를 보면 풀기 쉽지 않은 문제들이 좀 있었는데, 이번 년도에는 수업시간 중에 문제를 다 알려주셔서 편하게 공부했습니다.(수업 마지막에 출제하신 시험문제를 전부 보여주셨습다) 암의 위치(항문연 상방 cm)에 따라 어떤 암인지 구분하고, 그에 어떤 치료들이 있는지를 잘 정리해서 공부하시면 될 것 같습니다. *23: 항상 비슷비슷한 주제로 나오는데 막상 풀 때는 선지를 고르기 애매한 문제가 많이 나옵니다. 어떨 때 어떤 수술을 하는지 정확하게 아는 게 좋습니다. *22: 대부분 야마 또는 강조하셨던 곳에서 출제하셨다. *21: 야마를 변형하여서 자주 내시고 kmle 를 풀어보면 큰 도움이 된다. *구 가이드: 18 년엔 백성규 교수님과 배옥석 교수님 파트가 바뀌었다. 문제가 굉장히 까다로웠다. 야마도 없었기 때문에 체감 난이도가 더 높았다. 수업 중에 강조 해주셨지만 stage 다 외우고 그에 따른 수술을 다 알아야 했음.
손영길	O		15'~	*25 : 야마 잘 타십니다. 수업도 잘 하십니다. 이 부분은 크게 가르칠 내용이 많이 없다고 하시면서, 응급수술의 적응증(strangulation) + 충수돌기염은 수술해야 함을 많이 강조하셨고, 야마랑 많이 유사하게 문제가 나왔습니다. 복부 진찰 OSCE 때도 들어오셨습니다. *23: 작년과 비슷합니다. *22: 풀야마. 수업 중 강조하셨던 내용이랑 겹침. *21: 20, 21 은 풀야마, 19 야마는 18 야마 변형 과거보다 야마 보는 것이 더 중요해졌다. *구 가이드: 수업 잘 하신다. 야마 적당히 타심. 수업에 비해 몇몇 문제는 어렵게 느껴질 수도 있다.

안근수			고대	*25 : 수업을 아주 잘하십니다. 수업 때 강조하시는 내용 + 약간의 야마 변형이라 무난무난하게 야마 위주로 공부하시면 될 것 같습니다. *23: 작년처럼 올해도 퀴즈 형식으로 수업 진행하셨습니다. 퀴즈 낸 곳에서 문제가 많이 나온다고 말씀하셨고 실제로 그랬습니다. *22: 퀴즈를 내시고 맞춘 사람에게 상품을 주셨다. 중요 개념을 퀴즈로 내시고, 실제 시험 문제도 겹쳤던 부분이 있었기 때문에 퀴즈에 집중하면 좋을 것 같다. 놀랄 만한 상품도 있으니 용기 내어 이름을 외쳐보자. 중요한 내용을 강조하여 이해하기 쉽게 설명해주시기 때문에 수업만 잘 들어도 내용 정리가 된다. 살짝 탈야마하셨지만, 탈야마 하시더라도 강의록을 꼼꼼히 공부하면 풀 수 있을 것 같다. 한글로 용어 알아두는 것이 중요할 듯.
				*21: 21 년에도 담낭/담관 관련 문제가 나왔다. 강조하신 부분 잘 보고 들어가자. 소화기 1 에서는 내시는 범위가 어느정도 정해져 있는 것 같다(개인적 의견, 맹신 x) *구 가이드 : 수업 전에 문자 오셔서(총대 번호를 어떻게 구하신 지 의문) 3*3 빙고 만들어놓으라고 하심. 매우 좋으신 분. 수업 끝나고 빙고 만든 사람 상품 주신다. 산타근수. 해부학 파트라 내분비처럼 case 로 수업하시지는 않았다. 수업 때 강조하시는 것에서만 문제 나옴. 수업 중 강조하는 것만 다 외우면 맞출 수 있다. 담낭/담관 구분 잘하기!

이유진		15'~	*25 : 조곤조곤하게 수업 잘 하십니다. 수업시간 중에 중요한 부분도 알려주시고, 이정도만 알아도 된다 등 공부 가이드라인을 잘 잡아주십니다. 편하게 공부했던 교수님인 것 같습니다. 수업 때 간단한 질문 많이 하시는데 대답 잘 하셔야 합니다. 문제도 어렵지 않게 출제하십니다. 야마를 그대로 타진 않지만, 야마 부분이 중요한 부분이기에 그 부분 위주로 계속 출제가 됩니다. 그러므로 야마를 먼저 보고 그 부분 위주로 공부하시는 것을 추천드립니다. 소장질환/흡수장애는 강의록 마지막에 추가해주신 문제들에서도 나왔습니다. 변비/설사/체중감소는 강의록에 별표를 넣어 놓으셨고 해당 부분에서 문제가 나왔습니다. 저희 학번은 감염(1)을 듣고 소화기(1)을 바로 들어서 세균 외우는 게 크게 어렵진 않았습니다. 장염증성질환도 강의록 페이지는 많으나, CD 와 UC 를 비교하는 내용이 대부분이라서 공부하는 데 크게 어려움은 없었습니다. CD 와 UC 의 특징을 잘 비교하고, 사진 잘 봐두시고 치료제만 잘 외우면 문제가 쉽게 풀렸던 걸로 기억합니다. *23: 염증성 장질환 파트를 이해원 교수님과 김미정 교수님이 강의하시고, 소장/흡수질환과 설사/변비 파트를 강의하셨는데 강조하신 내용대로 무난하게 나온 것 같습니다. *22: 본래 이유진 교수님이 맡으셨던 파트를 모두 김정석 교수님께서 강의하셨다. *21: 비대면 강의로 진행해서 성격 관련해서는 잘 모르겠음, 18 년도에는 안 그러셨다고 함. 내시는 파트가 거의 정해진 것 같다. 강조하신 부분 잘 보고 시험 들어가자 *구 가이드: kmle 스타일. 친절하고 나긋나긋하게 수업 잘해주심. 단 조금이라도 선을 넘는 기색이 보이면 화내심. 18 년 업데이트: 그런 기색 전혀 안보였음 문제는 수업 중 강조하신 부분에서! 외울 게 많지만 외우면 맞출 수 있었다
-----	--	------	--

이주엽			15'~	*25 : 수업시간에 중요한 부분을 짚어 주십니다. 수업 잘 들으시고, 야마까지 보시면 부담 없이 공부하실 수 있습니다. *23; 작년과 비슷합니다. *22: 대부분 강조하셨던 곳 또는 야마에서 내주셨고, 강의록에 있는 문제도 잘 봐두면 좋을 것 같음 *21: 야마변형이 대부분이고 강의록에서 선지를 다 찾을 수 있음. 반복되는 선지가 많아 년도별 문제 다 풀어볼 것을 추천. *구 가이드: 소화기 간사. 중요한 것 다 집어 주시고 문제도 쉽게 내심. 헬리코박터 TBL 1 시간 하심. 문제는 쉬움 TBL 시험은 야마 탄다. 본시 문제는 TBL 과 다르나 강의록 열심히 읽으면 맞출 수 있음. 19 년도에 박경식교수님 파트였던 내시경 수업을 본인이 하심. 과거 야마와 경향도 비슷하고 쉬웠음.
정운경			고대	*25 : 수업 무난하게 잘 하십니다. 수업 마지막에 학생들 한 명씩 집어서 수업 내용을 물어보시고, 추가로 한번 더 수업 내용을 요약해 주십니다. 이 내용들 잘 체크해 두셨다가 야마 먼저 보신 후에 해당 내용들 위주로 같이 공부하시면 크게 어렵진 않으실 것 같습니다. (이전 가이드라인에서도 야마를 먼저 보면 내용이 정리가 된다고 했는데, 말 그대로 야마를 먼저 보시면 무슨 말인지 이해하실 수 있습니다.) *23: 작년과 비슷합니다. *22: 앞선 가이드 대로 야마 다 풀면 강조하셨던 내용이 알아서 정리된다. 대부분 야마 그대로 또는 변형해서
				내시므로 관련 내용을 잘 정리해 공부하면 충분할 것 같다. *21: 21 년은 비대면이라 그런지 quiz 없어짐 야마 보면서 공부하면 도움 많이 됨. 시험은 무난 *구 가이드: 수업 후에 quiz 내셨는데 그냥 summary 느낌이고.. 야마 다 풀면 강의 내용이 알아서 정리 됨.

조광범		고대	*25 : 강의록 페이지가 너무 많고, 야마도 별로 없는데, 말은 너무 빠르셔서 다들 멘붕이었습니다. 암의 심각도에 따라 어떤 처치나 치료를 할 수 있는지, 수술할 수 있는지 없는지, 수술 전후로 화학 혹은 방사선 치료를 할 수 있는지 등의 내용을 좀 강조하셨던 걸로 기억합니다. 수업 때 언급하신 내용을 선지로 내시기도 해서 수업을 잘 들으셔야 할 것 같습니다. *23: 안 들어오심 *22: 금년에는 TBL 로 진행하진 않으셨지만, 엄청난 양을 한꺼번에 수업하셨다. 내용도 어려웠고 시험문제도 어려웠던 걸로 기억. 수업은 열정적으로 해주신다. *구 가이드: 책임교수님. 17 년까지는 강의실에서 수업하셨지만 18 년에 4 시간 전부를 TBL 로 하심.. TBL 전에 1 시간 mini lecture 가 있는데, 이걸 교수님이 까먹으셔서 다른 날에 이현직 교수님이 들어오셔서 하심.. TBL 자료 수준 자체가 높고 어렵고, TBL 문제도 어렵고 TBL 수업도 어렵고, 문제도 어렵다. 우리 학번 필기총이 총 9 시간 걸려 필기할 정도로 말이 많으셨음. 단 CBT 실은 녹화가 안되니 녹음기 준비할 것. 19 년도에 TBL 수업 까먹고 늦게 오셔서 개인 시험은 보지 않았다. 본시 내용은 참공부. 그리고 교수님이 이 문제에서 어떤 답을 원하는지 잘 생각해보자. 출제자의 의도 파악하기.
채민철		20'~	*25 : 강의록이 조금 불친절했던 것 같습니다. 앞선 가이드라인대로 개념을 물어보는 문제들을 내십니다. 그래도 야마를 많이 타시는 것 같으니, 참공보다는 야마 위주로 공부하시면 편합니다. 풀야마였습니다. *23: 채민철 교수님은 특정 개념에 대한 정의를 꼭 나열하고 맞는 걸 고르는 식의 문제가 많이 나옵니다. *22: 강의는 하셨는데 복기된 문제가 없다. 아마 이전 야마와 유사하게 나왔던 것으로 보인다. 수업을 거의 강의록 전체를 읽는 방식으로 하셔서 공부하기에 어려움이 있었던 것으로 기억. *21: 박경식, 금동윤 교수님 강의내용과 많이 겹치는 내용이 다. 2021 년은 2020 년 18 학번 야마복기본과 굉장히 유사하게 출제됨. (선지변형)

2 년 연속 안 들어오신 교수님

배옥석			고대	*22: 안 들어오셨음 *구 가이드: 은퇴하셨지만 강의는 들어오신다. 18 년에 백성규 교수님이랑 파트 바뀜. 문제는 무난. 그러나 야마가 없어서 체감 난도는 조금 있음.
강유나			고대	*22: 안 들어오셨음 경북대로 가셔서 안 들어오실 것 같기는 하지만 법의학에도 들어오셨고 해서 일단 둡니다. *구 가이드: 병리학 때와 비슷. 수업 듣기 힘든데 양은 많음. 수업은 강의록으로. 야마 반, 수업시간에 강조하신 것 반. 책 사진 보라고 하시지만 시험에 나오는 사진은 구글에 검색했을 때 제일 위에 있는 사진이다. 수업 중 강조하시거나 병리 사진 특징을 말로 설명하신 것은 구글에서 사진 찾아보자.
신동우			20'~	*22: 안 들어오셨음 *21: 수업 시작하기 전에 뒤에서 한번 정리해줄 테니 그 부분만 보고가도 문제 풀 수 있게 해준다고 약속하심. 마지막에 4 줄로 정리해 주셨고 실제로 거의 그대로 출제하심

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	소화기(2)			학점 3 학점
과목 요약	간담채 파트, 3 주, 시험 1 번, 시간당 두 문제(84 문제), 재시 O(40 문제, 본시 탐) KMLE 큰 도움 되고, 학점이 크니 뽀공. 야마 많이 타고 수월하다. 동기들 간의 편차가 적음.			
올해 경향	야마 또는 야마 변형 문제가 많았습니다. 고대야마까지 보시는 것을 추천합니다.			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
강구정			고대	*25: 25 년도에 교수님께서 퇴임하셔서 교양같은 1 시간 들어오셨지만 시험은 출제하지 않으셨습니다. *23: 수업 시간에 추가로 공부해라는 말씀을 계속 하셔서 불안했지만 시험 문제는 수업 내용에서 크게 벗어나지 않았던 걸로 기억합니다. 상당히 꼼꼼히 강의록을 봐야 풀 수 있었습니다.지엽적인 문제를 잘 내십니다. 인문학 수업 같은 경우는 수업 태도 중요하게 여기셨습니다. 출석 수정하려고 교수님께 찾아간 학생들 하나하나 오늘 수업에서 인상 깊었던 거 물어보셨습니다. 인문학 문제는 매우 쉽게 출제하셨습니다. *22: 탈야마:) 이것도 매우 지엽적이고 강의록 포함 모든 걸 꼼꼼하게 보셔야 합니다. 의료인문 수업은 시험에 안 내셨습니다. *구 가이드: 야마, 수업시간 중 중요하다고 강조하신 것 내심. 그렇지만 꼼꼼히 봐도 못 맞추는 문제도 가끔 있다. 2019 년에는 의학 인문학 문제는 나오지 않았다. (야마는 임상의학총론 야마집에 있음)

구은정		18'~	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 말씀이 많이 느리셔서 졸릴 수도 있지만 설명을 꼼꼼하게, 쉽게 해줍니다. 야마도 잘 타주시고 그다지 어렵지 않게 출제하십니다. 개인적으로 당황스러웠던 문제가 1~2개 정도 있었습니다. *22: 전년 가이드라인엔 천사교수님이라고 적혀져 있지만 저희는 탈야마하셨습니다. 신생아의 외과적 질환 파트는 참공 필수입니다. 마지막 30 초 수업한 신생아 괴사성 장염에서 시험문제 나왔습니다. 신생아의 외과적 생리, 영아 및 소아 소화기 및 경부질환, 소아 간담도 외과적 질환은 야마탐니다. 그렇지만 신생아 외과적 질환은 참공 필수!! Kmle 도 푸세요
김미정	o	고대	*21: 장효정 교수님 내용하고 겹치는게 있습니다. 친절하시고, 영상 소견도 문제에서 설명해 주시는 등 학생 친화적으로 문제를 내십니다. 야마도 많이 나옵니다. *25: 문제 스타일은 야마와 비슷하게 내셨지만, 디테일한 것과 답은 달랐습니다. 말씀이 워낙 빠르시고 수업이 따라가기 쉽지 않으니 집중해서 잘 들으시면 좋을 것 같습니다. 영상 사진 보고 질환 맞출 수 있어야합니다! *23: 수업 속도가 매우 빠르셔서 수업 때 힘드실 수 있습니다. 야마를 많이 타십니다. 강의록과 야마에 나오는 사진을 주의 깊게 보시는 걸 추천합니다. *22: 사진이 정말정말 중요합니다. 항상 출제되는 부분도 있고 매년 새롭게 출제하시는 문제도 있으니 열공하세요. *21: 수업하는 속도가 좀 빨라서 필기총들이 좀 힘든 수업임. 말을 굉장히 빨리 하시고 비대면 수업의 경우 포인터도 없이 수업을 진행하셔서 따라가기 힘들었음. 그래도 야마 많이 탐. *구 가이드: 수업 잘 하신다. 문제는 무난. 사진 주고 어떤 질환인지. 간단하게 나눔. 야마 타신다. 그래도 혹시 모르니 시험 직전에 사진 눈에 속속 바르고 들어가자

김민재		2025	*25: 짚어주셨습니다. 수업 잘 듣고 강조하신 부분 잘 기억하시면 될 것 같습니다.
김용훈	o	고대	*25: 중간중간 시험문제 관련 언급도 해주시고, 야마 + 강의록 마지막에 있는 summary 에 있는 내용만 완벽히 알아도 문제 다 풀 수 있습니다. 거의 야마 타시고, 다르게 내더라도 야마와 같은 결의 문제를 내시니, YBL 잘하시면 큰 문제는 없을 것 같습니다 *23: 4 시간 수업인데 2 시간 반 정도 수업하셨습니다. 빨간 글씨+야마에서 낸다고 하셨습니다. summary 슬라이드에 중요한 내용이 있으니 그 부분을 중심으로 공부하시는 걸 추천드립니다. 수업 중에 중요한 부분 강조해주십니다. *22: 마지막 슬라이드에 정리되어 있어서 그것만 보시면 됩니다. (KMLE 까지도 필요 없어요) *21: summary slide 만 잘 봐도 많이 맞을 수 있고 핵심 내용 위주로 내심. 중요한 부분 강조해주시고 야마 탐. *구 가이드: summary 슬라이드랑 야마 잘 보면 다 맞출 수 있다

김태석		15'~	*25: 내용이 조금 산발적이지만 강조해주셨고 문제도 평이하게 나왔습니다 (간이식 교수님이셔서 간이식을 좋아하시는 것 같습니다). *23: 출석 주의하셔야 합니다. 마지막에 출석 부르셨고, 강의 중간에 들어오는 동기분들도 이름 확인하면서 출석 체크하셨습니다. 말투 친근하시고 좋으신 교수님입니다. 매번 내시던 곳에서 잘 내십니다. 야마 잘 타십니다. *22: 풀야마:) 수업시간에 낸다고 하신 부분에서 내십니다 *21: 야마 전부 타주신 것 같습니다. 간이식을 묻는 문제는 꾸준히 출제되는 것 같음. *구 가이드: 답은 간이식. 이 교수님 문제인지 분간하는 것이 중요 (19 년도에는 1 시간 들어오심)
류남희	o	고대	*25: 강의시간에 시험문제가 보이죠? 하시면서 강의록에 볼드체로 되어있는 것 2 개 출제하셨습니다. *23: 시원시원하신 성격의 교수님입니다. 수업도 큰 개념 위주로 강의하셨습니다. 졸지 마시고, 교수님 질문에 대답 잘
			해주세요. 시험은 주로 내시던 부분에서 출제하십니다. 야마 타시는 편입니다. *22: 갯갯희 교수님! 빨간색만 보시면 됩니다 *21: 양이 좀 많긴 하지만 중요한 부분을 알려주시고 중요한 부분과 그 주변부분에서 내는 것 같음. 야마 타는 편 *구 가이드: 진단검사의학 교수님. 양이 좀 많지만 수업시간에 문제를 알려주신다. 그것만 봐도 됨
배진목		2023	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: NEW! 23 년에 처음 담관염, 담관폐쇄, 기타 담도질환 수업 들어오셨습니다. 말씀이 빠르시고 수업도 빠릅니다. 수업 녹화 꼭 해두세요. 강의록에 나오는 문제와 사례 잘 봐두세요. 시험 문제도 그것과 유사하게 출제되었습니다. (IgG4, 급성 담관염 중증도 진단 및 치료) 진단 기준, 중증도 표를 잘 보셔야합니다.

변상준		17'~	*25: 풀야마입니다. 수업시간에 기출문제를 잘 보라고 하셨습니다. 부담없이 공부할 수 있습니다. *23: summary 슬라이드 내용을 중심으로 공부하는 것을 추천드립니다. *22: 마지막에 summary 페이지 있는데 그 주제 안에서 나옵니다. 기본적으로 종양 T stage 판단방법은 알고계세요(깊이 vs 크기) *21: 강의록 중에 빨간 글씨로 강조해주시는 내용이 많고, 마지막에 summary 부분을 보고 중요한 파트를 다시 공부하면 효과가 좋을 듯 합니다. 야마 많이 타시고, 관련된 내용 공부하면 될 것 같습니다. *구 가이드: 2019 때는 2018 야마 그대로 탔다. 양은 많지만 수업시간에 파트를 집어주셨다. 그것만 보자.
신경인		2025	*25: 올해 처음 들어오셨습니다. 수업시간에 문제 4 개 보여주셨고 그 중 3 문제가 유사/동일하게 나왔습니다. 수업도 무난하게 잘하시고 이해하기 쉽게 설명해주십니다. 강의록에 빨간 글씨 잘 보세요!
신동우	o	20'~	*25: 들어오지 않으셨습니다. *22: 들어오지 않음 *21: 20, 21 모두 같은 문제가 나옴. 내용은 어려우나 담관석 위주로만 출제하셔서 담관석 위주로 내용정리를 하고 나머지는 중요한 내용만 읽어보는것도 좋을 것 같음.

안근수		고대	*25: 내용도 무난하고 짚어주십니다. 지엽적으로 공부하실 필요는 없고 진단과 치료 잘 정리하시면 됩니다. *23: 올해도 빙고 게임 했습니다. 시험은 야마와 비슷하게 출제된 것 같습니다. 수업을 매우 잘해주시고 빙고로 선물도 주십니다. 내용도 크게 어렵지 않고 전체적인 틀을 잡으면서 공부하시는 것을 추천합니다. *22: 산타근수:) 수업 시간에 퀴즈 내시고 선물 주시고 밥도 사주십니다. 근데 시험은 야마 타지는 않고 적당히 공부하셔야 합니다.
			*구 가이드: 수업 전에 문자 오셔서(총대 번호를 어떻게 구하신지 의문) 3*3 빙고 만들어놓으라고 하심. 매우 좋으신 분. 수업 끝나고 빙고 만든 사람 상품 주신다. 산타근수. 해부학 파트라 내분비처럼 case 로 수업하시지는 않았다. 수업 때 강조하시는 것에서만 문제 나옴. 수업 중 강조하는 것만 다 외우면 맞출 수 있다. 담낭/담관 구분 잘하기!
원경숙	o	고대	*25: 극과 극으로 출제하셨습니다. 한 문제는 은근슬쩍 강조하신 부분, 한 문제는 강의록 마지막 페이지에 언급만 간단히 하신 부분.. 양이 많지만 야마는 안타시기 때문에 참공 하셔야 할 것 같습니다.. 공부할 때 까다로웠던 파트입니다. *23: 일찍 안 마쳐주십니다. 야마를 별로 안 타시는 것 같습니다. 양이 많습니다. 눈에 바르고 시험장에 들어가시는 걸 추천합니다. *22: 강의록이 rainbow~ 한시간 수업인데 슬라이드가 89 장(...)이었습니다 극악의 가성비.. 빨간 글씨 잘 보시고 사진 주의해서 보세요. *21: 야마를 타긴 타는데 안타는 내용 맞추기가 힘듦. 핵의학이라서 새로 보는 용어들도 많고 사진도 익숙하지 않아 수업 따라가기가 벅참. 중요한 내용을 빨간펜이나 파란펜으로 표시해주시긴 하는데 그것도 너무 많고 그냥 검정 글씨로 써져있는 부분에서도 문제많이 나옴. 탈야마하는 문제들은 그 슬라이드 내용을 그대로 외워야 풀 수 있는 문제들이 많음. *구 가이드: 야마 적당히 타는 느낌이다. 안 타도 양이 적고 쉽다.

이무숙		20'~	*25: 소화기(2) 파트에서는 중요하게 생각하시는게 딱 있으신 것 같습니다. 간암의 인터벤션 치료와 문맥고혈압의 인터벤션 치료 이렇게 두 주제에서 한 문제씩 내셨고, 치료법을 한글과 영어 섞어서 내시니 둘 다 잘 알아두셔야합니다. 야마를 그대로 내시진 않으시지만 보시면 이해하는데는 훨씬 도움이 되는 것 같습니다. *23: 이해하기 쉽게 설명하십니다. 고등학교 수업을 듣는 느낌입니다. 시험은 야마 선지변형이었습니다. 문제를 크게크게 내시기 때문에 큰 틀을 잡고 공부하는 것을 추천드립니다. 각 각 치료법을 명확히 알고 계시면 큰 어려움이 없으실 것 같습니다. 수업에 나오는 기법들의 전체 이름을 알아두시면 도 움될 것 같습니다. *22: 약자가 뭐의 약자인지까지 자세하게 아셔야 합니다. *21: 문제 굵직한 걸로 내십니다. 크게 정리해서 공부하고, 치료법과 관련된 약어들이 많이 나오는데, full name 한 번씩 생각하면 좋을 것 같습니다.
이혜원	o	17'~	*25: 수업 다 하시고 마지막에 A4 로 뽑으신 시험문제 옆에서 보시면서 강의 요약해 주셨습니다. 실제로 시험 문제도 요약해주신 내용에서 나왔고, 네 문제 모두 야마와 동일하거나 거의 유사하게 나왔습니다. 다만 야마에 복기가 안된 사진이 있을 수 있으니, 강의록에 있는 사진은 잘 보고 들어가는 게 좋을 것 같습니다. *23: 주로 조직 사진을 주시고 맞추게 하는 문제를 자주 내십니다. 사진을 눈에 잘 익히는 것이 좋습니다. 강의록 사진을 그대로 내십니다. 야마 꼭 보시고, 강의록 사진과 병명을 연관지어서 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. *22: 야마탐. 그래도 강의록 사진은 잘 보세요
			*21: 강의록 사진이 그대로 문제에 나와 강의록에 있는 사진과 병명을 기억하는게 좋을 것 같음. 야마 타심.

이희정		고대	*25: 수업시간에 설명 안하신 부분에서 출제하셨습니다. 이 파트는 내용을 더 찾아보며 참공하시는 것을 추천드립니다. *23: 사진을 눈에 잘 익혀두시면 좋을 것 같습니다. 수업 중에 강조해주시는 부분이 따로 없어서 시험 문제가 뭐가 나올지 감을 잡기 힘듭니다. *22: 경부에서도 한문제 나왔습니다. 아주 꼼꼼히 참공하셔야 합니다. *21: 강조된 부분이 잘 없고, 문제를 예측하기도 어렵다. 편한 마음으로 공부하면 될 것 같습니다. *구 가이드: 소아영상의학 교수님. 랩퍼... 본인은 빠른줄 모르시는 듯.. 문제는 야마 타심.
장병국		고대	*25: 내용이 꽤 어렵습니다. 원리도 잘 이해하고 암기할 부분도 잘 암기해야 합니다. 특히 Child pugh score 범위를 정확하게 암기하셔야 합니다. *23: 수업시간 꼭 채워서 수업하셨습니다. 주로 내시던 부분에서 출제하십니다. 계산하는 문제를 출제하십니다. *22: 대부분이 틀린 문제가 있었는데 야마 답이 잘못 내려온 것 같다고(...) 피드백 때 수업해주셨습니다. *21: 야마에서 출제된 부분에서 거의 출제하셨습니다. 계산 문제들이 출제되니 주의할 것. *구 가이드: 간 파트. 뇌색남. 수업과 내용은 어려웠으나 시험은 무난했다.
장효정		17'~	*25: 마지막 수업시간 끝날 때 중요한 부분 언급해주셨고, 그 부분에서 모두 출제되었습니다. 출제된 문제마저 거의 풀야마였습니다. 부담없이 마지막 정리 내용만 공부하셔도 충분합니다. *23: 중요한 내용을 강조해주셨습니다. 시험도 강조한 부분에서 대부분 나왔습니다. 야마도 잘 타십니다. *22: 전년 가이드라인엔 참공해야된다고 적혀져 있지만 2022 년엔 풀야마셨습니다. 시험 전날 수업 하시는데 수업이 도움이 안되니 개인적으로 YBL 을 추천합니다..ㅎ *21: 강의내용이 좀 많긴 한데, 깔끔하게 잘 정리 돼있습니다. 한글 강의록에서 강조하신 거 잘 보고, 야마 나왔던 것들 위주로 공부하면

				됩니다. 한 문제 정도가 강조되지 않은 곳에서 나오는 것 같습니다. *구 가이드: 책으로 수업하시고 마지막에 다 집어 주셨다. Quiz, case 꼭 보기. PK 가면 좀 까다롭다고 들음
정우진			고대	*25: 내용이 꽤 복잡합니다. HBV 와 HCV 의 내용이 상당히 많으니 특징, 진단, 치료 등을 잘 정리하여 공부하셔야 합니다. *23: 야마와 비슷한 문제가 많이 출제되었습니다. *22: Criteria 같은거 열심히 보시고 누가봐도 문제 나올 것 같은 부분에서 나옵니다. *21: 수업시간에 강조하신 부분에서 내셨고 문제가 KMLE 방식이 아니라 내신처럼 출제되니 강의록 잘 보는게 좋을 것 같음. *구 가이드: 간 파트. 수업 때 강조하신 거에서 내심. 야마 꼭 보자.
정은영				*25: 수업시간에 중요한 부분 알려주십니다. 그 부분만 공부하시면 쉽게 맞출 수 있게 출제하셨습니다. 강의만 잘 들으면 공부부담이 매우 적어집니다. *23: 1 시간 늦게 오신 대신, 1 시간 만에 모든 수업을 하셨습니다. 출석도 도착하셔서 바로 두 번 다 하셨습니다. 수업 중에 중요한 부분을 잘 강조해주십니다. 그 부분들 위주로 문제가 출제됐습니다.

조광범	○	고대	*25: 역시나 올해도 쉽지 않으셨습니다. 거의 모든 문제 탈야마하셨고, 강의록 혹은 수업을 꼼꼼하게 봐야 맞출수 있는 문제가 많았습니다. 그래도 상식으로 맞출 수 있는 문제도 있었고, 문제 선지 자체에서 답을 좁혀나갈 수 있는 문제도 있었습니다. *23: 올해도 TBL 안 했습니다. 급만성 췌장염 파트는 큰 틀을 잘 잡아서 공부하시는 것을 추천드립니다. 사진을 잘 사용하시므로 사진도 눈 여겨 보시길 추천드립니다. *22: 세트문제의 주인. 어려운 문제 복기안된 문제는 전부 조광범 교수님이 내셨다고 보시면 됩니다. 강의록만 보시면 안되고 모든 걸 보셔야 하는데 그래도 맞출 수 있다는 보장은 없습니다...ㅎ *21: TBL 수업 그냥 녹화강의로 진행해서 무난했음. 사진내는 슬라이드에서 계속 내는 것 같음. 야마는 절반정도 타는 것 같고 구체적인 수치를 시험에 내기도 함. *구 가이드: 책임교수님. 17년까지는 강의실에서 수업하셨지만 18년에 4시간 전부를 TBL로 하심.. TBL 전에 1시간 mini lecture가 있는데, 이걸 교수님이 까먹으셔서 다른 날에 이현직 교수님이 들어오셔서 하심.. TBL 자료 수준 자체가 높고 어렵고, TBL 문제도 어렵고 TBL 수업도 어렵고, 문제도 어렵다. 우리 학번 필기총이 총 9시간 걸려 필기할 정도로 말이 많으셨음. 단 CBT 실은 녹화가 안되니 녹음기 준비할 것. 19년도에 TBL 수업 까먹고 늦게 오셔서 개인 시험은 보지 않았다. 본시 내용은 참공부. 그리고 교수님이 이 문제에서 어떤 답을 원하시는지 잘 생각해보자. 출제자의 의도 파악하기.
-----	---	----	--

황재석			고대	*25: 온라인 수업진행하고 마지막 1 시간 정리시간만 현강으로 했습니다. 문맥고혈압/복수/간경변 파트는 교수님께서 강조해주시는거 위주로 원리를 잘 이해해야하고, 자가면역질환 파트는 꼼꼼하게 필기본 읽고 정리를 하시면 좋을 것 같습니다. *23: 말이 빠르십니다만 설명 잘해주십니다. 학생들에게 말 많이 거십니다. 어려운 질문은 아니고 철이 많이 쌓이면 어떤 증상이 생길 것 같냐는 등의 질문입니다. 강의실 잘 돌아다니십니다. 아이패드 조심하세요. 시험은 야마에서 자주 출제되는 내용이 많이 나왔던 것 같습니다. 한글 강의록 꼼꼼히 읽어보시면 좋을 거 같습니다. *22: 케이스 잘 보세요! 강의록에 있는 케이스 문제와 KMLE 를 다 주의깊게 보셔야 합니다. *21: 중요하다고 하시는 부분에서 반복 출제되는 것 같으나 매년 변형되거나 새로운 문제가 출제되는 것 같아 강의록 참고부가 필요할 것 같음. *구 가이드: 동굴 목소리로 썰렁한 농담 하심. 강의는 나쁘지 않은데 수업 늦게 마치심. 문제는 쉬움
-----	--	--	----	--

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	내분비			2 학점
과목 요약	수업보다 KMLE 가 아주 많이 도움 되었다. 사실상 KMLE 스타일로 거의 모든 문제가 나온다. 모든 숫자를 달달 외우고 세세하게 암기한다고 해서 잘 볼 수 있는 과목이 아니라, 문제에 주어진 수치를 보고 바로 진단 및 향후 검사, 치료를 떠올릴 수 있는게 중요함. 자칫하면 시험장에서 멘붕이 올 수 있다. KMLE 의 알고리즘 완벽 숙지!! 매우 도움됨. 필자 개인적으로 매우 양이 많고 알고리즘이 많아 헛갈리는 부분도 많은 과목 TOP1. 다른 시험과 다르게 90 분이라는 시험시간이 턱없이 부족하게 느껴졌다. 미리 자신만의 문제풀이 알고리즘을 세워두는 것도 좋아보임.			
올해 경향	다른 강의와 다르게 시간당 3 문제 출제하십니다. 성적을 LMS 를 통해 개인적으로 공개해주셨습니다.			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
문교철	O	O	고대	25 : "수업 중 교수님 강의록 잘 보고 YBL" 교수님 강의록에는 시험에 출제하신 문제가 전부 별표로 표시되어 있고 수업 중에도 강조해주십니다. 야마에도 관련 문제가 매년 돌아가면서 출제되기 때문에 고대 야마까지 풀어보는거 추천드립니다. 갓 문교철 쌤.. *23: 내분비 시간에는 수업시간 중에 문제 나올 것을 짚어 주시고 짚어준 부분의 고대 야마가 그대로 출제되었음. *22: 빨간 글씨에서 대부분 출제, 형성평가도 중요! 하지만 한 문제는 빨간색으로 표시되어 있지 않았는데 구야마(엄청 옛날)에서 그대로 나왔다. 모든 야마+빨간 글씨+형성평가! *21: M2 대세조 과목의 호르몬과 신호전달 수업과 같은 강의록이다. 야마를 모두 풀어보면 절반정도 타실 때도, 타지 않을 때도 있는데, Group 2a 신호전달, 인슐린에 관련된 모든 내용, cAMP, 임상응용 등이 많이 출제되는 파트이다. 강의록에 기반하여 글 한 줄 가져와서 문제나 답으로 출제하는 경우도 많고, 몇 번 생각해서 답을 도출해야 하는 경우도 있다. 올해에는 절반정도? 야마를 타신 것 같고, 자주 출제되는 파트에서, 자주 물어보는 개념들을 위주로 출제하셨다.

				*구 가이드: 본 1 때 하던 것 그대로. 생화학 강의록 호르몬 파트 쪽 읽어주시다 가심. 강의 때 언급하신 부분만 시험에 내셨음!
신형찬			19'~	25 : 믿으시면 됩니다. 5 분 늦게 들어오셔서 5 분 일찍 마쳐 주십니다. 저희가 보는 강의록과 교수님 수업용 자료가 달라서, 수업 때 빨간색 표시를 잘 보셔야 합니다. 빨간색 표시된 내용 위주로만 보시면 맞힐 수 있는데 전부 야마에서 출제된 내용이라서 사실상 해당 내용 + 야마만 보시면 됩니다. 단 소화기(1) 때는 특정 텍스트와 사진들에 빨간색 표시를 해 두셨고 정말 그 사진들과 텍스트만 나왔다면, 내분비 때는 특정 질환 3 개의 이름에만 빨간색 표시를 하셔서, 해당 질환 자체를 공부해야 됐습니다. 그래도 양이 안 많고 전부 야마를 꽤 타시니 수월하게 공부하실 수 있습니다. *23: 원래 ppt 에 빨간 글씨로 적어주셨지만 수업 안 듣는 학생이 많다고 없애심. 수업시간에 어디서 출제하시는 지 짚어주시니까 수업 집중해서 듣기 (대부분 출제하시던 곳) *22: 빨간 글씨 페이지는 완벽 공부하기. 밑에 내용까지!!
임승순	O		고대	25 : "체액균형 조절 호르몬, RAAS 기능 달달 외우기" 수업 중 교수님께서 RAAS 는 '이 시간에 이것만 알아도 될 정도로 중요하다'라고 말씀하실 정도로 강조하십니다. 형성평가에서는 레닌과 ANP 의 기능에 대해 묻는 문제를 출제하셨고, 시험에서는 항이노호르몬과 angiotensin II 의 기능에 대한 문제를 출제하셨습니다. 수업 중 강조하지 않은 부분에서도 한 문제 출제하셨기 때문에 전체적인 개념을 익히는 것도 필요할것 같습니다. 수업 스타일은 조곤조곤 자세히 설명해주시는 편입니다. *23: 항상 나오던 체액 균형의 손상에서 한 문제가 출제되었으며 복기되어 있지 않지만 체액균형 조절 호르몬에서도 문제가 출제되었음 *22: 중요하다고 하셨던 부분에서 야마를 변형해서 출제하시기 때문에, 그 부분이라도 열심히 공부하세요!

				*21: 체액 균형 호르몬, 체액균형 손상 부분에서 항상 출제하셨고, 올해도 2 문제는 여기서 출제되었다. 1 문제는 탈야마였다. *구 가이드: 생리학과 비슷하게 다 읽으심. 내용 자체도 쉽고 중요한 부분 집어 주시고 문제도 거기서 나옴. 문제는 본 1 생리처럼 말장난 치지 않고 쉽고 무난했음. 19 년도에 박재형교수님이 하심.
이성용	○	○	고대	25 : "탈야마...호르몬 작용 알아두기" 원래 대부분의 과목에서 야마를 타시던 교수님인데 올해는 전부 탈야마하셨습니다. 수업 중 강조하신 부분에서 내기도 하고 강조하셨어도 안 내기도 하며, 강의록에 있는 붉은 글씨, 파란 글씨, 이탤릭체 전부 문제 출제와는 상관없습니다.. 그래도 문제 출제 경향을 분석하자면 호르몬이나 약물의 작용 기전을 묻는 문제를 주로 출제하시는것 같습니다. *23: 야마 그대로 출제되었음 *22: 부신피질 호르몬 제제 강의에 대한 문제는 출제하지 않으셨고, 21 년과는 달리 탈야마는 없었다. 매우 쉽게 내심. *21: 은근 탈야마 문제도 출제하셨다. 하지만 아주 쉽거나 거의 야마 그대로 출제하셨다. *구 가이드: 마찬가지로 본 1 약리보단 쉬움. 갓성용. 풀야마. 믿고 따르자. 이상하게 내분비는 매년 한 문제가 새로 나왔다. 수업 중 강조하신 약이었다.
강석진	○		17'~	*22: 강의록이 아예 바뀌면서, 야마가 사라졌다. (모유수유가 사라짐 $\pi\pi$) 강의록 열심히 공부하면 맞출 수 있는 정도. 22 년 문제를 타시지 않을까요...? (근데 복기가 덜 됐어요 π) *21: 간사 교수님, 항상 출제하시는 유형대로 출제하셨다. 출제하는 부분과 스타일을 잘 체크해서 그 부분을 위주로 공부를 하는 것이 효율적이다. 성장 장애&성분화 장애 파트는 수업 전에 호르몬과 신호전달(문교철 T) 수업의 해당 파트를 복습한 후 공부하면 이해하기가 더 편하다. KMLE 소아과 각론 II_내분비 질환 파트를 풀어보면 도움이 정말 많이 된다.

				*구 가이드: 학생 눈 한번도 안 쳐다보시고 강의록 줄줄 읽다 가심. (17 년 까지는 김흥식교수님 파트) 문제는 야마 참고하라 하셨고 야마 변형. 중요한 부분 집어 주심.
김미경	○	○	고대	25: 수업은 잘 하시지만, 성격이 조금 까다로우십니다. 교수님 질문에 대답 잘 하시고 최대한 수업태도를 좋게 유지하시는 것을 추천합니다. 문제는 거의 야마 부분 위주로 출제되었지만, 강의록을 꼼꼼히 다 봐야 맞출 수 있는 문제를 1~2 개정도 출제하십니다. 야마부분 위주로 공부하시고, 시간이 남으시면 강의록을 정독하고 시험을 치시면 매우 도움이 됩니다. 야마 내용이 들어 있는 페이지는 다 봐야 합니다. Kmle 도 풀어보시는 걸 추천합니다. *23: 책임교수님. 내분비에서 가장 많은 내용을 수업하시고 야마와 kmle 보면 큰 도움이 됨. 수업시간에 중요하다고 언급하는 게 있는데 알면 좋을 듯. 수업 열심히 듣는 태도 중요함 (질문하면 대답잘하기 등) CPX 시간에 학생보고 앞에 나와서 시켜보시니 미리 공부해놓는 것이 좋을 듯 *22: 야마에서 요구하는 내용은 완벽하게 숙지. (숫자, 표 하나도 빠뜨리지 않기) 100 점 받고 싶으면 한국 당뇨 가이드라인을 참고하세요. (야마풀이 참고) 형성평가도 많지만 막상 문제로 내시진 않으셨다. *21: 책임 교수님, 야마를 타지 않는 것 같지만, 아주 많이 출제하는 부분들이 존재한다.(진단기준, 위험인자 등) 야마를 보면 여기까지 외워야 하나 하는 부분들이 있으니, 공부하기 전에 미리 체크하고 들어가면 효율적이다. 하지만 몇 문제는 정말 예상하지 못한 곳에서도 출제하시고, 강의록에는 없거나 대충 배우지만, KMLE 에만 나오는 개념에서도 출제하신다. KMLE 는 꼭 풀어보는 것이 좋다. *구 가이드: 연락 드릴 때 전화 전에 문자 먼저 드리기. 수업 잘 하시고 학구파셔서 문제는 조금 어려움.. 진단 기준을 매우 꼼꼼하게 봐야한다. 강의록에 없는데 강의 중에 말씀하신 것도 필기 잘해서 봐야함. 꼼꼼하게 공부해야 한다.

김엘	○		고대	25 : "풀야마" 내분비에서는 항상 풀야마 타십니다. 도파민 친화제(고프로락틴혈증 치료), optic chiasm, pituitary apoplexy 가 답입니다. *23: 수업태도 조심해야함. 풀야마 *22: 믿음으로! 수업태도 주의, 스탠딩책상 쓰지 마세요. *21: 야마 그대로 출제하신다. 수업 태도 주의, 정숙 *구 가이드: 따로 정리, 19 년도에는 이전에 내신 문제를 풀이 준비하게 하셨다. 문제는 야마 그대로.
김천수		○	고대	25 : 갑분 생화학입니다. 교수님께서도 이 파트 내용이 어려움을 인지하고 계십니다. 다만 야마를 보면 인지'만' 하고 계신 것 같습니다. 그 정도로 야마 문제들이 다 다른 부분에서 출제되어서 공부가 막막했습니다. 강의록을 전부 보기는 힘들고, 야마에 나왔던 내용이 포함된 페이지를 본다는 마인드로 공부했던 것 같습니다. 강의록 중간에 나오는 급성 뇌병증 표는 낼 때마다 학생들이 많이 틀린다고 하셨는데 실제로 내셨고, 걱정과 달리 문제를 매우 쉽게 내셨습니다. *23: 시험 얼마 남지 않은 시점에서 매우 방대한 양을 수업하심. 2023 에는 야마 거의 안 타셨고 오답률 제일 높은 2 문제를 출제하셨음. 참공하는 게 좋을 듯. *22: 시험 하루 전 학생 모두를 멘붕에 빠뜨리신 교수님① 이전까지 가이드에서는 탈야마 하신다고 적혀있었는데 2022 년에는 탈야마 문제가 없었다! *21: 야마 잘 안타신다. 대사 질환을 이해하는데, 생화학 내용이 기본 base로 깔린다. (AA 대사, 지질 대사, 당 대사 등, but 몰라도 외우는데 상관 없음) 내용이 굉장히 많기 때문에, 질병의 임상소견- 검사방법식이요법(치료법) 등 시험에 자주 출제되는 부분들을 따로 정리해서 공부하는 것이 효율적이다.

				*구 가이드: 소아과 파트. 강의록 줄줄 읽으심 ppt 는 따로 안 주신다. 총대는 물 준비 필수!! 없으면 달라 하신다. 자주 늦으시니, 한 10 분은 늦어야 연락 드려 볼 것.
--	--	--	--	---

김혜순		○	14'~	25 : "형성평가 꼭꼭 분석하고 공부하기" 내분비 첫 시간, 총론처럼 수업하시고 형성평가를 내셔서 그 당시에는 문제 풀기가 까다로울 수 있지만 이후에 하은영 교수님 수업을 다 듣고 나면 충분히 풀 수 있습니다. 시험 문제도 형성평가와 동일하거나 유사하게 출제되고, 교수님께서도 '형성평가 공부하면 시험 풀 수 있고, 보기와 선지는 조금 바뀔 수 있다'라고 말씀하십니다. 내분비 끝나갈 때쯤 배우는 MEN 강의는 교수님께서 직접 'MEN1 에서 한 문제 출제'라고 알려주셨고 야마와 거의 동일합니다. *23: 전범위에서 2 문제, 다발성 내분비 종양에서 3 문제 출제하심. 전범위의 경우 3 문제를 출제하셔야 하지만 1 문제를 안 내는 대신 문제를 학생 직접 만들어서 제출하라고 하심. 2 문제 중 한 문제는 학생이 직접 만든 문제들 중에서 하나 출제하심. 다발성 내분비 종양은 야마 변형하여 내시거나 중요한 부분에서 내심 *22: OT 는 내분비 전체질환 중 아무데서나 KMLE 형식으로 내신다. 내분비 전체를 배우고 공부하다보면 풀 수 있다. (틀릴 수도 있다.) 세 문제중 한 문제는 과제로 대체되었다. *21: '내분비 기능의 조절과 평가'라는 OT 형태의 총론 수업을 하시는데, 앞으로 내분비 블록에서 배울 점들을 간단간단하게 소개해주시는 수업이다. 그런데 이 수업에서도 문제를 출제하신다... 다르게 말하자면 한 강의 안에 2 주간 배우는 대부분의 질병들이 소개되고, 내분비 전체 범위에서 아무 내용이나 출제하신다. 내분비 공부를 다 한 후에 문제를 다시 풀어보면 잘 풀린다. 과제가 있었고, 구글링이나 해리슨을 참고하면 된다. 이 과제가(rapid ACTH test, dexamethasone test) 뒤에서 굉장히 중요하게 배우는 내용이고, 시험에서도 몇 문제씩 꼭 출제되는 부분이다. *구 가이드: 수업 잘하시고 잘 가르쳐 주시는데 조금 빠름. 대답!! 잘 하면 매우 좋아하심. 책상 위에 해리슨 많이 올려져 있으면
-----	--	---	------	--

			매우 좋아하심. 시험은 KMLE 에서도 출제하시니 R 형 까지 꼭 다 풀어보기!! 단답식 한 문제는 나올 문제 집어 주셨음. 19 년에는 어느 한 시간은 수업 다 하시고 갑자기 해리슨 글 3 개 집어 주시며 읽고 레포트 제출 시키심. 시험 문제도 거기서 낸다고 하시고 거기서 다 나옴.
--	--	--	--

박소윤			2023	*23: 올해 처음으로 들어오심. 수업시간 중간에 나올 부분들을 집어주심. 제 1 형당뇨병은 야마타셨지만 성장조절과 성장장애 치료와 사춘기 이상 성분화 장애 및 부신성기 증후군은 야마 안 타심.
안근수	○	○	고대	25 : 수업 잘하십니다. 시험 직전 마지막 수업인 걸 알고 계신 건지, 정말 핵심만 집어주셨고 전부 문제들로 나왔습니다. 야마 잘 보시고 수업만 잘 들으시면 되는 교수님입니다. *23: 야마그대로 내시거나 변형. 야마 위주로 공부하면 도움이 될 듯. 22: 직접 제작하신 드라마 'Insulinoma', 올해 새로 제작하셨다고 한다. 야마 타십니다! *21: 수업시간에 강조하신 부분과 야마에서 출제하셨다. 수업 마지막에 나오는 부분을 말해주셨다.(하지만 마지막 파트는 2020 년에 찍은 영상이었다...) *구 가이드: ppt 로 수업하시며 수업은 case 위주로 내시고, 문제는 case 랑 그대로 나눔. 야마 보면 됨. 무난. 새로 나오는 문제는 강조하신 부분!
원경숙		○	고대	25: 핵의학은 늘 어렵습니다. 익숙하지 않은 scan 이름들이 등장하며 강의록 페이지도 너무 많습니다. 수업만 들으면 맞힐 수 있다고 하셨으나 그렇게 쉽지만은 않았던 걸로 기억합니다. 오히려 강의록에는 없고 수업 때 언급하신 내용을 내시기도 했습니다. 야마에 출제된 내용을 숙지하시고, 수업을 잘 들으시는 걸 추천합니다. *23: 한 문제는 야마 거의 그대로 출제됨. 수업양이 많으시고 참공하고 야마는 알아두는 게 좋을 듯. *22: 시험 하루전 학생 모두를 멘붕에 빠뜨리신 교수님② 갑상선 스캔에 대한 야마 문제로 시험 전에 동기들의 의견이 분분했으나, 정작 그 문제는 내지 않으시고 세세한 부분에서 출제하셨다. 강의록이 아니라 그냥 내분비 전체에 대해 제대로 공부해야 맞출 수 있는 문제도 있었던 것 같음. 핵의학인 만큼

				핵종은 완벽하게 숙지! 형성평가도 시행하였는데, 문제로 출제하시진 않으셨다. *21: 야마 잘 안타셨고, 문제가 굉장히 어려웠다. 강의록에 적혀있지 않지만, 교수님이 추가로 설명하신 부분에서도 문제가 출제되었다. 교수님 말씀을 꼼꼼하게 필기하고, 공부할 필요가 있다.. *구 가이드: 핵의학 파트, 18 년의 경우 수업시간이 모자라서 뒷부분은 못 나갔는데 거기서도 시험문제 내셨음.. 수업 때 자지 말기 "자려면 뒤에 나가서 수업 들어라."하심. 태도 주의
유지홍			20'~	*23: kmle 참고해서 공부하면 충분히 다 맞추실 수 있을 정도로 출제하심 *22: 인간 KMLE, 내용은 많았으나 KMLE 로 차근차근 공부하기! 공부하면 틀릴 문제는 없다! *21: 시상하부&뇌하수체 파트라 내용이 조금 많지만, 질환별로 내용을 잘 분류해보고, KMLE 를 풀어보면서 각 질환마다 어떤 조건(수치)들이 문제에서 주어지고, 어떤 부분을 근거로 질환을 유추해가는지 잘 정리해보면 문제풀기가 편하다.
이무현	○		16'~	25: 25 : 부갑상선 파트는 내용도 안 많고 primary 와 secondary 의 구분 기준을 알고, 증상, 수술 방법, 예후 등을 잘 구분하시고 야마 잘 보시면 문제를 푸시는 데 어려움은 없을 것 같습니다. 내용이 적었던 부갑상선에 비해 갑상선 때는 내용이 너무 많아서 놀랐습니다. 야마가 없는 줄 알았으나 2018 1 차에 출제하신 문제들이 있었고, 실제로 많이 비슷하게 나왔습니다. 수업 때 강조하시는 내용 + 빨간 텍스트 + 야마를 잘 보시면 됩니다. 강의록의 초음파 사진을 시험에 그대로 내십니다. *23: 야마타시지만 변형하여서 출제하심. *22: 부갑상샘 외과적 치료, 야마 타시지만 변형이 되므로 야마에 해당하는 부분은 공부! *21: 내용이 적고, 중요한 부분을 알려주시며, 수업 마지막에 다시 한번 더 정리해 주신다. 강조한 부분에서 전부 출제하셨으며, 야마 그대로 출제하셨다.

				*구 가이드: 99 학번 유방내분비외과 신임교수님. hips 출신. 수업 무난하게 하시고 야마는 따로 없었지만 문제도 어렵게 내지 않으셨다.
조난희			21'~	*23: 안 들어오심 *22: 너무 귀여우신 교수님...♥ 완전 KMLE 형식이고, 수업에 중요한거 말씀해주시고, 야마도 타심. *21: 올해 새로 들어오신 교수님이라 야마가 없다. 각 질환의 진단과 치료를 강조하시며 이 부분을 중점적으로 공부하라고 하였고, 시험 문제 역시 이부분에서 출제하신 것 같다.
조지형	○		고대	*23: 강의록 마지막에 문제들 중에서 몇 문제 골라서 변형하여 출제하심. 야마도 대부분 거기서 출제된 것들임. *22: 마지막에 띄워주시는 문제 10 개 (= 야마) 중에서 출제됨. 야마 부분만 공부해도 됨. *21: 작년 야마와 유사하게 출제하여 보통 문제 조건은 유사하지만, 질문이 변화하였을 것이라고 수업 중간에 말해주셨다. (ex. 치료방법? -> 치료 후 처치?) 작년 문제를 가지고 여러가지 상황을 공부해보면 도움이 될 것이라고 하였고, 실제로 작년 야마 선지와 정답을 조금 변형하거나, 그대로 출제하셨다. 야마 선지 분석을 꼼꼼히 하고 들어가면 어렵지 않게 풀 수 있다.
조호찬		○	고대	*23: kmle 큰 도움이 됨. 수업 잘 듣고 야마와 kmle 모두 확실히 아는 게 좋을 듯 *22: KMLE 형식으로 출제 + 야마. 강의록 뿐 아니라 KMLE 의 내용까지 숙지하기! 한국 당뇨 가이드라인을 봐야 맞출 수 있는 문제가 한 문제 나오긴 했습니다... (야마풀이 참고) *21: 당뇨병 파트에서 2 시간, 부신 파트에서 1 시간 들어오셨다. 수업을 하면서 중요한 부분을 알려주셨고, 여기에서 시험 문제가 많이 출제되었다. 야마도 중요하지만 KMLE 가 많은 도움이 된다. 당뇨병 치료 약제의 경우 KMLE 에 정리된 표가 있는데, 이 표에 강의 내용을 추가 필기하면 정리가 조금 더 편하다. 부신 파트는 수업 전에 호르몬과 신호전달(문교철 T) 수업의 해당 파트를

				복습한 후 공부하면 이해하기가 더 편하다. *구 가이드: 수업태도 매우 중요! 특히 조는 거 조심할 것! 시험 전 교수님 본인의 마지막 수업 끝나고 바로 형성평가 치는데 사실상 베이스 업 10 점짜리니 출석은 필수!!
한유진	○		17'~	*23: 야마와 kmle 참고하여 공부하면 큰 도움이 될 듯. 수업시간 마지막에 질문하시는데 적극적으로 대답하는 게 좋을 듯. *22: 야마 변형 + KMLE !! 공부하면 적당히 맞출 수 있는 수준으로 출제하셨음! *21: 강의록에 별표 or 중요한 부분을 골라주셨고, 여기에서 출제되었다. 항상 출제하는 형식으로 출제하셨고, KMLE 를 풀어보면 도움이 많이 된다. 뇌하수체 질병과 마찬가지로 질환별로 분류하여 특징과 접근법을 잘 정리해보면 도움이 된다. *구 가이드: 강의록에 별표 치신 슬라이드에서 문제 출제 예고하심. 말고도 야마 변형해서 내시므로 선지 분석 중요.
하은영				25 : "질환별 진단 기준 위주로 공부하기" 올해 처음 수업에 들어오셨고 특별하게 시험 문제를 집어주시지는 않습니다. 하지만 수업을 잘 하시기 때문에 수업 잘 듣고 각 질환별 진단 과정을 특징별로 이해하면 어렵지 않게 문제 풀 수 있습니다.
김세진				25 : 올해 새로 들어오신 교수님. 야마도 없고 어떻게 공부해야 하나 막막했던 교수님이지만, 수업시간에 아시겠죠? 와 같이 설명하시고 한번 더 학생들에게 물어보는듯한 말투를 하시는데, 그 부분이 중요한 부분이었습니다. 그 부분 위주로 출제되었고, 나머지 문제는 KMLE 스타일로 출제되어서 수업 잘 들어서 중요한 부분 체크하고, 공부하는 KMLE 문제들을 많이 풀어보시는 것을 추천합니다. 이전에 소아 파트를 맡으셨던 교수님의 야마도 어느정도 겹쳤던 것 같으니 시험 전에 꼭 풀어보시기 바랍니다.
한유진				25 : 이번엔 다른 교수님이 하시던 파트를 강의하셔서 야마가 없었는데, 교수님이 수업을 다 하시고 마지막에 시험문제를 다 내고 왔다고 하시면서 복습을 꼭 해주십니다. 그 부분이 전부 시험문제로 출제되었습니다. 강의내용이 많아서 힘들었지만, 마지막에 다 집어주셔서 많이 도움이 됐습니다. 교수님이

				강조하시는 부분만 잘 들으시면 공부량이 매우 적어집니다. 당뇨 진단 기준이 중요하고 김미경 교수님 때도 나오기 때문에, kmle 를 풀면서 잘 익히시는 걸 추천합니다.
박재형			11'~	*21~ 안 들어오심. *구 가이드: 수업 양도 많지 않고, 시험 문제도 쉬웠다. 중요한 부분 강조.
권선영			고대	*21~ 안 들어오심. *구 가이드: 병리 때와 마찬가지로 수업태도 조심!! (1 교시면 다들 5 분 일찍 오기!) 강의 깔끔하게 잘 해주시고 문제도 강조하시는 거 내주신다. 야마&수업 때 강조하신 것!!

본과 1 학년 가이드라인				
과목명	신경계			학점 6 학점
과목 요약	양도 많고 학점도 처음 맞이하는 6 학점짜리 과목이다. 야마를 많이 타서 재밌게 공부했다. 2 차시때 교수님 각각 3 문제씩 받아서 2 문제를 출제하고 나머지 한 문제는 재시 때 사용한다고 한다.			
올해 경향	양만 보면 꽤 부담스러우나 야마를 많이 탔고 출제 포인트를 알려주신 교수님들도 많아 막상 공부 자체는 할 만 했다. 시험 난이도는 쉬움~중간 정도였다. 성적은 LMS 를 통해 개별 공개되었다.			
교수님	(O 표시)		Since	출제 성향
	YBL	안탐		
TBL				
2025				TBL 진행하지 않았습니다.

2023				*1 차: 수업 시작 시 푸는 퀴즈는 전년도를 그대로 들고오시는 문제도 있지만, 재작년 혹은 그 전의 사진을 들고오는 경우도 있어 구할 수 있다면 과거 문제를 여러해 풀어보면 도움이 된다. 수업 중 교수님이 문제를 풀어주실 때 교수님이 문제를 푸는 흐름을 이해하면 시험을 치는 것은 그렇게 힘들지는 않 다. *2 차: TBL 수업 전, 미리 한글 강의록을 읽고 들어가면 도움이 많이 된다. 시험 문제는 야마와 비슷해 보이지만 일부 변형된 문제도 있었다. 그래도 항상 같은 주제로 출제하시는 것 같 다. TBL 문제와 야마로 개념 정리를 잘했다면 충분히 풀 수 있다.
2022			21~	*2 차: 수업 전날 과대를 통해 한글 강의록을 전달해주고 공부해 오라고 하신다. 수업 시작 시 10 문제 정도의 퀴즈를 각자 풀고 팀끼리 논의하여 답에 대해 발표하는 형식의 수업이다. 한글 강의록과 전년도 TBL 퀴즈 문제를 풀어보고 수업을 들으면 도움이 많이 된다. 대신 전년도 문제와 비슷한 것 같지만 변형이 많이 되니 꼼꼼히 문제를 읽어야 한다. 시험은 야마는 타는 문제도 있고 안타는 문제도 있지만 나오는 내용이 나오며 TBL 퀴즈 문제와 관련해서 강조하신 부분들을 잘 공부하면 헛갈리더라도 답을 고를 수 있을 것이다.
2021				*21: TBL 로 진행하는 허혈성 뇌혈관 질환은 TBL 문제와 강의록을 꼼꼼히 공부하는 것이 좋습니다. 특히, 허혈성 뇌혈관 질환의 치료 기준을 명확히 알아두는 것이 좋을 것 같습니다.
손성일			고대	TBL *구 가이드: 강의 깔끔하게 하시고 강조하신 부분에서 출제. 무난하고 시험문제 가지고 와서 문제형식 말씀해주심(ex; "혈관사진 보고 맞추는 문제다").
박형중			19'~	TBL
홍정호			14'~	TBL

1 차				
박재형			고대	*25: 감각생리에 대해 수업하셨지만 본인 파트는 과제로 대체하셨습니다. *23: 야마에서 본 문제가 또 나오므로, 전년도 문제가 아니더라도 야마는 모두 체크하자. *22: lateral inhibition 은 반복해서 출제된다. *21: 수업도 무난하시고 문제도 무난하다. 기초신경 내용의 복습 느낌이 강하다. *구 가이드: 갓재형! 문제 다 짚어주시고 그마저도 야마 탔었 음. 기종평 문제였음. 19 년에는 몇 년도 문제만 보세요. 하시 고 거기서 다 나옴.
배재훈			고대	*25: 강의를 잘 들으시면 이해가 잘 됩니다. 문제는 풀야마였습니다. 야마 위주로 공부하시는 것을 추천합니다. *23: 기종평 기출은 찾아보고 시험을 치자. 개인적으로 이형 교수님 파트와 섞여 소뇌 파트가 조금 헷갈렸다. 야마를 탄다기 보다는 공부한 만큼 문제를 풀 수 있는 교수님이라고 생각한다. 수업은 명강이나 시험 문제는 조금 어려웠다. *22: 강의 내용은 많으나, 이해하기 쉽게 강의 잘 해주심. 야마 빈출 주제가 있지만 야마를 그대로 출제하지는 않으시기 때문에 해당 주제에 대해 꼼꼼히 공부할 필요가 있음. *21: 수업을 매우 잘하시고 나까지 똑똑해지는 기분이 드는데 문제는 조금 어려울 수 있으니 착각하면 안되고 꼼꼼히 공부해야한다. *구 가이드: 수업 태도 중요하다. 강의는 항상 잘하신다. 17 년도에는 마지막 시간에 수업태도 안 좋아서 교수님 열 받으시고 문제 정말 어렵게 내심. 19 년도에는 고대 야마도 많이 나왔다. 고대까지 꼭 보기.

송대규		○	고대	*25: 올해는 문제를 짚어주셨습니다. 짚어주신 부분을 정확하게 공부해야 합니다. *23: 나을 법한 곳에서 문제를 내셨으나, 한 문제는 너무 과한 내용을 가져 오셔서 동기 중 해당 문제를 맞춘 동기가 아무도 없는 것으로 예상된다. 교수님께 너무 과한 내용을 질문하면, 교수님이 즐겁게 심화 문제를 들고오실 수 있다... 그 외에도 문제를 꼼꼼히 읽고 야마와 다른 부분을 캐치하면 좋다. *22: 대부분 야마를 타셨으나 강의록을 꼼꼼히 봐야 알 수 있는 문제도 출제하셨다. 자율신경계 표는 잘 외워야 한다. *21: 난이도가 전에 비해서 낮아졌지만 그래도 신경계 1 차에서 가장 어려운 편... 자율신경계 표 같은 것은 달달 외우자 *구 가이드: 본 2 되어서도 생리학은 헬. 보통 큰걸 안 물어보 고 강의록 괄호 안에 있는 지엽적인 것 하나만을 물어보심. 꼼꼼하게 공부해야 한다. 19 년에는 간단간단하게 물어서 맞힐 만 했다. 대신 그림이나 그래프 설명하신 부분에서 나옴.
이성용	○		고대	*25: 야마 안타시고 강조도 딱히 안 하십니다. 하지만 문제는 평이하게 출제되기 때문에 세세한 약물 작용과 부작용을 공부하기보단 약물의 대표적 작용기전 먼저 다 공부하고 시간이 남으면 세세하게 보시는 것을 추천합니다. *23: 풀야마. *22: 맞는 선지를 바꿔서 출제하실 수는 있지만 야마를 타신다. *구 가이드: 이 때 처음으로 탈야마. 1 차를 잘 쳐서 2 차 때 탈야마 하신듯. 공부해도 풀기 어려운 수준이었고 심지어 강의 록 내용과 달랐던 것 같음. 19 년도에는 약간 탈야마 하셨는데 유수연교수님 수업내용으로 풀 수 있었음.
				*23: 풀야마. 중요하다, 시험에 내겠다 하시는 부분이 야마와 일치한다. *22: 20 학번에서는 수업 시작 전 작년과 똑같이 출제했다고 미리 언급하고 시작하심. 문제는 작년 그대로 풀야마(주관식 문제).

권세민			19'~	*25: 안집어주시는듯 째어주시고 (중요하다 하시는 것 외에도 빨간글씨, 빨간 네모박스) 문제도 쉽게 내주십니다. *23: 풀야마 *22: 수업도 깔끔하게 진행해주시고, 문제도 수업 중 강조하신 곳과 야마에서 쉽게 출제됨. *21: 수업도 되게 무난하시고 수업 중에 강조해주신 부분 위주로 공부하면 좋다.
김인수	○		고대	*25: 양이 상당히 많습니다. 하지만 문제는 거의 풀야마였습니다. 역시 중요한 것이 중요하기 때문에 기출문제 나온 부분 위주로 공부하시는 것을 추천합니다. 척수신경로 문제는 고대야마와 다른교수님 야마변형으로 출제되었습니다. *23: 강의록에 내용이 엄청 많고, 수업은 사진 위주로 하시나 시험은 강의록 내 줄글 위주로 나온다. 영어 용어가 한국어로 번역되면 어떻게 쓰이는지 알면 문제 풀 때 도움이 된다. *22: 강의록에 내용이 매우 많아 쉽지 않은 수업. 문제는 주로 야마 선지 변형으로 출제하시고 강의록에 없는 내용도 선지로 출제하시기 때문에 과거 야마 선지 위주로 먼저 보기. *구 가이드: 양이 엄청 많고 강의록 보기가 너무 어려웠지만 야마 변형으로 출제하시니 야마 중요!! 바뀌는 선지는 수업 중에 강조하신 부분. 강의록 줄줄 읽으심.
김재현			2023	*25: 째어주시지만, 정확하게 공부하지 않으면 살짝 헛갈릴 수 있습니다. 째어주신 부분을 정확하게 공부해야 합니다. *23: NEW! 올해부터 새로 들어오셨다. 김창현 교수님 파트인 뇌혈관 해부를 담당하셨는데, 김창현 교수님과 친하다고 말씀하시면서 문제를 다 받아왔으니 걱정하지 말라고 하셨다. 강의록도 똑같았고, 예상대로 풀야마였다. 이창영 교수님 두개강내압 항진 파트도 담당하셨다. 1 문제는 이창영 교수님께서 주신 문제를 낸다고 하셨고, 1 문제는 새로 냈지만

				어렵지 않게 내셨다며 큰거 위주로 외우라고 하셨다. 실제로 문제 쉽게 내셨다.
권민용			2025	*25: 모든 문제를 집어주셨으나, 기초신경때와 다르게 출제하신 문제들 중 상당히 풀기 까다로운 문제들이 출제되었습니다. 게다가 강의시간에 강의록과 다르게 설명을 해주셔서 집어주신 부분 강의록을 정확하게 안 읽으면 틀릴 수밖에 없는 문제도 있었습니다. 집어주신 부분은 설명하신 내용보다 더 깊게 공부하는 것을 추천합니다.
정하경			2025	*25: 올해 새로 들어오셨고, 내용도 처음 들으면 이해하기 어려운 내용이라 공부할 때 매우 까다로웠던 기억이 납니다. 하지만 문제는 매우 쉽게 출제하셔서 문제를 맞히기 위한 공부를 한다면 강의록에 있는 내용을 이해하기보단 단편적인 내용 암기를 하시는 것을 추천합니다. 시험을 치고 나니 강의록에 빨간색 글씨 부분과 강의시간에 교수님 PPT 에 빨간색으로 칠해진 부분에서 출제된 것을 확인했지만, 다른 과목에서는 그렇지 않았기 때문에 빨간색만 공부하시면 안됩니다...
손성일			고대	*25: 강의는 잘 하시고 문제도 4 개중 3 개 어떤 문제 출제했다 주제 정도만 알려주셨는데, 개인적으로는 도움이 전혀 안됐습니다. 강의시간에 언급, 설명한 적 없는 문제만 4 개 출제하셨습니다. 이 파트는 참공하시거나 야마만 보시는 것을 추천합니다. 작성자는 참공했지만 참공해도 맞추지 못하는 문제가 있어서 효율이 좋지는 못했습니다.
홍정호	○		고대	수업을 잘 하시고 풀야마 타셨습니다. 옛날 야마까지 보시는 것을 추천합니다.

김창현			고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 강의록은 길지만 풀야마. 시간이 너무너무 남는다면 강의록을 한 번 읽어두면 다른 교수님 파트에서 도움을 받을 수는 있다. (굳이 할 필요는 없다.) *22: 수업 태도 조심. 마스크 쓰고도 하품할 때 입 안가리고 하는 것 싫어하심(마스크 벗으면 특히 주의!!) 시험은 강의록에서 가르쳐주시는 문제 안에서 전부 출제됨. 믿고 가는 풀야마 교수님. *21: 풀야마(수업 중 말하실 것이다.) *구 가이드: 물 준비!! 갓창현!! 수업도 잘하시고 수업시간에 문제 다 알려주고 수업만 잘 들으면 다 맞음. 알려준 것도 야마임. 태도주의. 하품 입 가리고 하기. 풀야마지만 고대야마까지 다 봐야함.
이창영			고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 수업을 통해 명쾌한 이해를 하는 것은 어렵지만, 문제는 항상 나오던 곳에서 나오므로 수업 난이도에 비해 시험 부담감은 적은 편. *22: 수업 내용을 강의실에서 바로 이해하기 어렵다. 시험은 항상 출제되는 주제에서 나오니 과거 야마 해설들 참고해서 공부하면 큰 도움. *21: 외울 것은 많지만 수업은 무난하고 조금은 지엽적인 부분과 그림도 다 외워야한다. *구 가이드: 감사 교수님. 목소리 좀 허스키해서 수업 듣기 힘들 수 있지만 시험은 짚어준 것 + 야마! 야마 50 새로운 것 50. 새로운 것 중 몇 개는 강조해주신다.

고용산			2021	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 야마입니다. *22: 문제는 작년과 같은문제 다 짚어주시고 주관식으로 나옴 아예 서술형 빈칸 비워놓는 부분도 같음, 믿으세요 교수님 들어오셨을 때 떠들고 있으면 기본적인 예의 지켜달라고 말씀하심, 수업 태도 주의! *21: 문제 어디서 나오는지 알려주심. 주관식으로 출제하므로 알려주신 부분 꼼꼼히 봐야함. 수업이 끝나면 교수님께서 내용을 질문하시는데, 이름 부르면 네 하고, 일어나서 답을 알면 말하면 되고, 모르면 모른다고 말씀드리면 됨, 잘 모른다고 앉아서 답변 없이 조용히 있으면, 기본적인 예의는 지켜달라고 강하게 말씀하신다.
-----	--	--	------	--

이형	O		고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 야마를 꼼꼼히 보면 어렵지 않게 문제가 풀린다. 신경학 적 검사 실습, 배재훈 교수님 수업을 열심히 들으면 이형 교 수님 파트를 공부할 때 도움이 된다. *22(1 차): 수업을 잘 하시지만, 강의록을 보고 공부하기가 쉽지는 않다. 뇌신경을 검사와 같이 차례차례 설명하시는 걸 잘 들으면 도움이 된다. 항상 출제하는 곳에서만 출제하시기 때문에 야마 출제된 주제 부분을 꼼꼼하게 보면 된다. *구 가이드: 책임 교수님. 명강의. 책임 교수님이시니 수업태 도 중요함!! 시험은 풀야마!
----	---	--	----	---

장혁원	○		고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 야마에 매년 출제되는 유형이 있습니다. 이 유형을 잘 공부해두셔야 합니다. (1 차 범위 수업도 3 차 때 진행하셨습니다.) *22(1 차): 강의록에 없는 혈관 영상 사진이 출제 되었는데 해부학적인 뇌혈관 구조를 잘 알아야 맞출 수 있었다. 수업 시간에 문제를 찍어 주신다. *22(3 차): 수업 후에 어디서 문제 냈는지 알려주심, 거의 야마타는 것 같음, 근데 강의록에 없고 야마에 있는 문제도 나온듯? 그냥 외우세요! *21: 수업 끝에 작년 문제 받았죠?라고 말씀하시고 야마타심 *구가이드: 몇 개 짚어주시고 거기서 내심. 18,19 년도에 한 문제는 기억 안 난다고 안 짚어주심.
-----	---	--	----	--

2 차				
송대규		○	고대	*25: 담당인 생리학이라는 과목이 원래 어렵기도 하고, 페이지당 빼곡한 글자 수, 매우 지엽적으로도 내시는 교수님의 특성 상 항상 공부할 때 부담이 큰 교수님이었는데, 어째서인지 올해는 본인이 출제하신 문제들의 답을 그냥 알려주셨습니다. 저희가 불쌍해 보였던 걸까요? 내년에는 어떻게 하실 지 모르겠습니다. *23: 한 문제만 매번 내시던 곳에서 출제하셨다. 참공하는 것을 추천한다. *22: 올해만 그런진 모르겠는데 학생들에게 강의록의 일정 부분을 짚어서 설명하게 하신다. LMS 에 과제로 미리 공지된다. 발표하는 사람은 가산점 있다고 하니 점수 받고 싶은 사람은 미리 한글강의록 읽어가면 될 것 같다. 내용이 어렵고 수업을 듣고 한번에 이해하기 힘들 수 있다. 뇌의 각 부위와 관련된 역할이나 질병을 빠뜨리는 것 없이 꼼꼼히 공부하는 게 좋다. 시험은 한 문제는 내시던 곳에서, 한 문제는 1 차 범위에서 내셨다. 부디 올해만 그러셨길 바란다... *21: 야마 타긴 하지만 참공부해야 맞출 수 있는 문제도 내심

				*구 가이드: 본 2 되어서도 생리학은 헬. 보통 큰걸 안 물어보고 강의록 괄호 안에 있는 지엽적인 것 하나만을 물어보심. 꼼꼼하게 공부해야 한다. 19 년에는 간단간단하게 물어서 맞힐만 했다. 대신 그림이나 그래프 설명하신 부분에서 나옴.
이성용			고대	*25: 원래 이성용 교수님은 전통적으로 풀야마를 타셨지만, 올해 신경계를 포함한 본 1 모든 과목 문제를 새로 출제하셨습니다... 다만 신경계 2 차 난이도는 크게크게 공부해도 무난하게 풀 수 있는 난이도로 출제되었습니다. *23: 풀야마 *22: 탈야마라 해서 겁먹었는데.. 풀야마 *21(3 차): 고대야마까지도 그대로 타긴 하지만 뇌전증약물은 완전 탈야마

				*구 가이드: 이 때 처음으로 탈야마. 1 차를 잘 쳐서 2 차 때 탈야마 하신듯. 공부해도 풀기 어려운 수준이었고 심지어 강의록 내용과 달랐던 것 같음. 19 년도에는 약간 탈야마 하셨는데 유수연교수님 수업내용으로 풀 수 있었음.
김근태		17'~	*25: 마찬가지로 학생 한 명씩 시켜서 한 문단씩 읽게 시키고 수업하시는데, 수업 내용도 정말 중요한 것만 가르치시고 시험문제 출제한곳도 아주 많이 강조하셨습니다. 그 부분만 공부해도 모든 시험문제를 맞출 수 있는 난이도로 출제되었으니, 교수님이 강조하신 부분만 암기해도 될 것 같습니다. *23: 한 명씩 앞으로 불러서 강의록 읽으라고 하신다. 이후 교수님께서 강의록 내 중요한 부분만 읽으시는데 그것만 공부하면 된다. 중요한 부분도 여러 번 강조하시기 때문에 수업 시간에 잘 들으면 된다. 야마도 많이 탄다! 조용원 교수님 문제도 쓱 알려주신다ㅎㅎ *22: 한글 강의록 준비 필수! 수업만 들어도 맞출 수 있음. 강조하시는 부분 확실히 알면 조용원 교수님 문제 푸는데도 도움이 됨. *21 년도: 수업시간에 아주 강조하시는 부분만 확실하게 알아도 됨. 거의 야마 변형으로 냄. 수업시간에 강의록 준비해왔는지 확인하면서 한명씩 나와서 읽게 시킴 *구 가이드: hips. 돌아다니시고 학생에게 책을 읽게 하심. 수업 재밌게 하시고 강의록으로 수업하심. 시험문제 가르쳐 주시는데 그게 또 야마. 수업 중 강조하신 내용만 다 알아도 충분하다. 본인 신세한탄 하시다가 쿨하게 가심. 태도주의. 강의록 꼭 준비하기. 19 년도에는 수업 전에 일찍 들어오셔서 뇌전증에 대해 몇 가지 질문하셨는데 그게 조용원 교수님 문제였음. 그러나 답은 안 가르쳐주시고 "중요합니다"하고 가심.	

이준석			2025	*25: 올해 처음 들어오신 교수님입니다. 강의록에 문제 출제하신 페이지에 빨간 별표로 표시해 주셔서 부담을 크게 덜 수 있었습니다. 빨간 표시에 해당하는 이전 담당 교수님 야마 보시는 것을 추천 드립니다.
변준철			2022	*25: 시험 직전에 두 시간 강의에 약 200p 정도 되는 강의록을 수업하셔서 개인적으로 부담스러웠던 파트입니다. 소아신경계를 수업하시는데, 출제하신 부분을 세세하게는 아니고 큰 범위 안에서 알려주셨지만, 범위 자체도 크고 문제도 꽤나 지엽적으로 어렵게 출제되어 참공이 필요한 파트입니다. 오답률 1 위 문제도 여기서 출제되었습니다. *23: 강의록에 체크 되어 있는 부분이 있습니다. 체크된 부분 이 좀 많지만 대부분 거기서 나왔던 것 같습니다. *22: 김준식 교수님이 퇴임하시면서 새롭게 들어오신 소아 교 수님, 올해가 처음이라 야마탈지 안탈지 모르겠다. 학생들 집중을 위해서.. 강의록을 일부만 주심.. 수업 끝나고 원본 올려주심, 중요한 페이지에 별표해주시는데 별표가 많아서 그냥 봐야함..꼭 그 페이지에서 나오는것도 아닌 것 같음
강민성			2025	*25: 올해 새로 들어오셨습니다. 강의스타일이 강조는 전혀 없으셔서 공부할 때 매우 막막했던 기억이 납니다. 하지만 역시 중요한 것이 중요합니다. 이전 담당 교수님 야마와 비슷하게 출제되었습니다. 야마 출제된 부분 위주로 공부하시는 것을 추천드립니다.

권세민				*25: 강의 마지막에 정리하면서 이게 중요하고, 이것만 알면 시험에는 지장이 없을 것입니다 라고 하였고 역시나 중요하다고 하신 2 개가 출제되었습니다. 그것마저 풀야마였습니다. 야마 보시는 것을 추천합니다. *23: 문제 나오는 포인트를 집어주셨습니다. *22: 야마 타주시고 딱히 어렵게 변형해서 내신 문제는 없습니다. *21: 갓세민, 수업시간에 3 개 알려주시고 2 개 출제하셨다.
김인수	o		고대	*25: 양이 너무 많습니다. 하지만 모든 문제가 야마변형으로 출제되었습니다. 야마만 봐도 많기 때문에 일단 야마 선지들을 정확히 분석하시는 것을 추천합니다. *23: 전년 동일 *22: 야마 기준 위 아래 내용을 자세하게 외우면 풀 수 있는 문제가 많습니다. 그런데 올해는 척추후방인대골화증 부분의 탈야마가 있었어서 척추질환의 경우 질환별로 정리가 필요할 것 같습니다. 세세한 부분을 변형해서 내시니 꼼꼼하게 외우시는 것을 추천드립니다. *21: 매번 출제하시는 곳에서 출제, 선지는 항상 변형하심, 출제하시는 부분 표시해두고 그 슬라이드에 있는 지엽적인 내용도 다 외워두는 편이 좋음, 시험 문제 풀 때 헛갈리는 경우가 많으므로 야마 선지도 꼼꼼하게 분석해두면 도움 됨 *구 가이드: 양이 엄청 많고 강의록 보기가 너무 어려웠지만 야마 변형으로 출제하시니 야마 중요!! 바뀌는 선지는 수업 중에 강조하신 부분. 강의록 줄줄 읽으심.

석흥렬				*25: 강의 내용이 살짝 어렵게 느껴질 수 있으나 정리만 잘 하면 쉽게 공부할 수 있는 파트입니다. 세세한 내용보다는 진단과 치료 부분을 제대로 공부하시는 것을 추천합니다. *23: 야마 변형이 많은 것 같습니다. *22: 야마 어느정도 타고 변형해서도 많이 내심 중요한거라 YBL 하되, 그부분 강의록 꼼꼼히 보는게 좋을듯..! *21: 야마를 어느 정도 타기는 하지만 다 타시지는 않음, 수업시간에 강조하는 부분에서 출제 많이 됨, 야마에 없는 내용이라고 대충 볼 수 있는 곳에서도 가끔 출제되니, 야마, 강의록, KMLE 모두 꼼꼼하게 공부하는 것이 좋을 것 같음 *구 가이드 : 나긋나긋 조곤조곤. 문제는 안 알려주시지만 수업시간에 중요한 것에서 강조하시고 그게 출제됨. 그러나 R 형이라서 힘들.
정하경			2025	*25: 올해 새로 들어오셨습니다. 강의 마지막에 시험문제 출제 어떻게 하셨다고 언급해주셨습니다. 언급해주신대로 형성평가에서 1 개, 나머지 언급하신 파트에서 1 개 출제되었으나, 나머지 파트에서 출제하신 문제가 다들 사진을 제대로 안 보고 넘어가서 오답률이 높았습니다.
송봉일				*25: 강의시간에 출제하신 문제 부분을 다 알려주십니다. 그 부분을 정확하게 공부하시는 것을 추천합니다.

조용원			고대	*25: 수업이 조금 난해하고, 문제와 강의록이 1 대 1 대응까지는 아니어서 공부할 때 조금 힘들었으나 시험은 수업을 다 들었다면 무난하게 풀 수 있는 난이도로 나왔습니다. 조용원 교수님 문제는 김근태 교수님이 모두 출제하셨습니다. *23: 참공하시기 바랍니다. *22: 세세한 내용까지 참공해야하는 교수님입니다. 주로 탈야마를 하시기 때문에 강조하시는 부분이랑 세세한 내용들을 다 같이 보시는 걸 추천드립니다. *21: 문제는 수업을 열심히 듣고 강의록을 꼼꼼히 공부하면 맞출 수 있는 정도의 평이한 문제를 내셨던 것 같습니다. 선지에 있는 내용이 강의록에는 없지만 수업시간에 교수님께서 강조하신 내용들도 있습니다. 작년과 재작년 야마가 없어서 기출을 분석하기는 어려웠습니다. 김근태 교수님 수업시간에 강조된 부분에서 출제된 부분이 꽤 많음(ICP-1, 수면일지) *구 가이드: 수면파트 강의인데 왜 다 자냐고 뭐라하심. 수업 태도 신경쓰고 2 차 때 수업시간에 1 차 수업내용도 강의하셔 서 시험내냐고 물어보니까 얼버무리셨는데 안 나옴. 야마 조금 탐. 찾아보라하시는건 꼭 찾아보기. 19 년도는 다들 조사 안 해서 그런지 탈야마함. 모든 파트가 탈야마였다. 강의록에서 선지 반 정도는 찾아 볼 수 있었다.
김엘			고대	*25: 수업시간에 이 페이지에 답이 있다며 출제하신 부분을 알려주셨습니다. 1 문제만 출제하셨습니다. 야마 그대로 출제되었습니다. *23: 야마 + 문제를 다 스포하셨습니다. *22: 풀야마 *22(3 차): 왕왕풀야마 *구 가이드: 문제 다 알려주셨다. Ex) 작년 문제만 보세요~

이재호	○		고대	*25: 2 문제를 집어주셨는데, 1 문제는 강의록에 있는 arnold chiari syndrome 기출문제를 보시면서 이거 그대로 냈다 하셨는데 갑자기 internal capsule 문제를 내셨습니다. 헷갈리신 것 같습니다. 그래도 문제가 어렵지 않았고 항상 강조를 잘 해주시니 강조해주신 부분 공부하시면 될 것 같습니다. *23: 야마에 매년 출제되는 유형이 있습니다. 이 유형을 잘 공부해두셔야 합니다. *21: 야마 똑같이 출제
김현아	○		14'~	*25: 수업을 다 하셨지만 문제를 출제하지 않으셨습니다. *22: 매번 비슷한 유형이지만 올해는 탈야마 *21: 야마 그대로 많이 타고 거의 중요한 부분에서 내심 *구 가이드 : 강의 열심히 들으면 무난하다. 수업 중 강조하신 내용! 19년에는 작년 문제 수업 중에 같이 풀고 작년 문제는 안 낸다고 하심.
김창현			고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 풀야마. 문제 다 알려주셨다. *22: 풀야마, ppt 에 시험 문제가 있다. 수업 듣기 힘들어도 믿을맨 갓창현이다. 대신 줄거나 하품 대놓고 하는 것은 안좋아하시니 수업 태도 주의해야 한다. 질문도 많이 하신다. 앞자리 긴장하자. *21: 수업시간에 시험 문제를 말씀해주십니다. 따라서 수업 중에 나온다고 말씀하신 부분을 위주로 야마를 먼저 보고 해당 부분을 공부하는 것이 도움이 될 것 같습니다. *구 가이드: 물 준비!! 갓창현!! 수업도 잘하시고 수업시간에 문제 다 알려주고 수업만 잘 들으면 다 맞음. 알려준 것도 야마임. 태도주의. 하품 입 가리고 하기. 풀야마지만 고대야마까지 다 봐야함.

유수연	○		고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 수업을 잘 하시기 때문에 수업 중 강조한 부분과 야마 위주로 공부하면 충분하다. *22: 해외연수 가셔서 수업에 들어오지 않음 *21(2 차): 강조하신 부분이 명확하고 중요한 부분만 잘 알아도 맞출 수 있다. *구 가이드: 말 빠르고 동영상으로 문제 내시고 수업 시간에 동영상을 보여주심. 수업 잘 하시니 열심히 잘 들으면 된다. 영상 꼭 보기, R 형으로 약 내시니 약은 꼼꼼히 다 외우기.
이창영			고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 풀야마 *22: 풀야마, 나오던 곳에서 골라서 내신다. 구 가이드처럼 목소리 허스키하셔서 수업 듣기 힘들지만 야마 잘 타시고 이창영 교수님 수업 내용과 관련된 다른 파트도 많아서 잘 들어두는게 좋지 않을까 싶다. *21: 수업시간에 중요한 부분을 짚어주십니다. 또 야마에

				나왔던 문제와 유사한 형태로 출제되기 때문에 기존의 기출에서 나왔던 부분에 해당하는 내용을 공부하는 것이 도움이 될 것 같습니다. *구 가이드: 간사 교수님. 목소리 좀 허스키해서 수업 듣기 힘들 수 있지만 시험은 짚어준 것 + 야마! 야마 50 새로운 것 50. 새로운 것 중 몇 개는 강조해주신다.
--	--	--	--	--

이현아	○		고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 야마 많이 타지만, 고대야마까지 보는 것을 추천한다. *22: 풀야마 절반, 절반은 야마 변형인데 어려웠음.. 특히 인지기능장애 검사 방법 문제 어렵게 내셨습니다 π 유수연 교수님 파트(이상운동질환)는 올해 처음 수업하신 부분이라 강조하신 부분에서 문제 내셨습니다. *21: 수업만 보면 막막할 수 있는데 야마를 매우 타기 때문에 야마내용 위주로 보는것을 추천. 수업때 질문을 종종 하시는데 대답을 많이 안하면 싫어하심 *구 가이드: 간사교수님. 태도주의. 수업 늦게 오면 뭐라고 하심. 반말 하심. 수업 때는 굉장히 깐깐해 보이시는 촌데레이지만 애기 자주 하면 편한 교수님. 1 차 때 시험을 잘 쳤더니 2 차 때 어렵게 내심. 대뇌피질의 해부와 기능 파트 수업하실 때 이런거 듣기만 해라 시험에 어떻게 내겠느냐 했는데 진짜 안 나옴. 본시는 야마 변형이었는데 재시는 탈야마 하셨다고 함.
이형	○		고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. * 개원하신다고 들었으니 24 년에는 안 들어오시지 않을까요 *23: 풀야마. 교수님께서 말씀이 많으신 편이지만 거의 야마 그대로 내시기 때문에 YBL 추천한다. *22: 야마 풀어보면 어렵지 않게 문제를 풀 수 있다. *21: 거의 야마 그대로 *구 가이드: 책임 교수님. 명강의. 책임 교수님이시니 수업태도 중요함!! 시험은 풀야마!
김상표		○	고대	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 전년 동일 *22: 야마 타시지만 매년마다 물어보는 내용은 다릅니다. 병 의 진단, 치료 , 특징을 바꿔서 물으심. 강의록 조직사진 그대 로 옮겨쓰는 경우가 많기때문에 사진과 강조하신 부분도 봐 두세요.

				*구 가이드: 신경병리학. 17 년까지 야마타시다가 18 년에 탈야마. 수업에서 안 가르쳐도 문제 내심. 안 가르쳐도 내시는 내용은 MS! 19 년에 탈야마. 강의록 다 보고 참 공부하기. 사진 중요!
김해원			16'~	*25: 들어오지 않으셨습니다. *23: 전년 동일 *22: 주로 수업시간에 강조한 내용 위주로 내시고, 야마에서 헛갈리게 변형해서 내십니다. 방사선 원소의 표기방법들을 다 묶어서 알아놓으시는 편이 좋을 것 같습니다. *21: 야마를 타시지만 그대로 내시지 않고 변형해서 출제하심. 해당 내용 세부적으로 참공부하기. *구 가이드: 피피티 빨간박스만 보면 됐다. 80 퍼는 야마타고 몇 개는 어려웠음. 수업 중에 자는 학생에게 질문하심. 양은 적으나 공부를 애매하게하면 문제 풀 때 많이 헛갈린다. 강조하신 건 완벽히 알자.